核心價值

關懷、專業、效率

宗　旨

提供安全、優質的醫療照顧

促進民眾和同仁的健康

培養優秀醫療人才

願　景

成為民眾最信賴的健康照護體系

臺灣醫療品質協會
2020年品質改善成果發表競賽

提升內科加護病房病人失禁性皮膚炎之照護品質

參賽組別：初階組

圈　　名：CEOs二圈

團隊成員：李穎俐、陳亭君、張庭碩、李姍珊、朱麗雯、鐘麗芬、黃文佩、莊玟玲、邱婉君、楊俊杰

輔 導 員：紀婉玉

活動期間：2019年04月01日～2020年04月30日

2020 年 10 月 15 日

2020 年品質改善成果發表競賽-初階組
摘要內容
〔提升內科加護病房病人失禁性皮膚炎之照護品質〕

圈名：CEOs 二圈

壹、計畫：

一、主題選定

本活動旨在從對於進入加護病房(ICU)之新病人開始，針對 ABCDE 組合式照護項目：認知評估(Assessment)、通氣—微氣候管理(Air-Microclimate)、保護屏障(Barrier)、病人狀況(Condition)、藥物(Drug)，以及組織環境(Environment)，檢討改善重症病人失禁性皮膚炎(Incontinence-associated dermatitis; IAD)之照護，降低 IAD 發生率，提升照護品質。

二、依實證文獻結果設定目標為：

1.IAD 發生率由 14.71%下降至 7.35%(改善幅度 50%)。

2.失禁病人 IAD 發生率由 31.25%下降至 12.90%。

貳、問題結構與對策措施探討：

本圈以課題達成型 QC Story 做為品管改善工具：

一、課題明確化

匯集 ABCDE 組合式照護項目，以系統圖法依序討論並展開掌握項目，選定醫療團隊評估知能、醫療團隊照護行為、IAD 評估工具、尿布床墊被褥材質、瀉劑/止瀉劑用藥後評估、IAD 照護能力 6 項重要掌握項目。

二、攻堅點選定

經圈員評分後依 80/20 法則並為達成較高期望水準選定前 6 項攻堅點：促進正確的 IAD 照護行為、促進醫療團隊 IAD 評估的信效度、新增適用的 IAD 評估工具、管理皮膚週邊微氣候、增列年度教育訓練計畫、促進導致腹瀉用藥及排便之監測為改善重點。

三、方策擬訂

以腦力激盪進行二次方策展開擬定 35 項方策，由圈員評分後，依分數高低、80/20 法則選出 7 項方策：增加攝入排出量跳出排便次數警示、系統開立醫囑時出現排便用藥決策支援、IAD 教育訓練納入學習歷程計畫、擬真教學、案例討論、IAD 評估工具資訊化、皮膚通氣照護標準化為主軸。

四、最適策追究

本次改善活動，圈員發展 IAD 分級整合照護，實施四項主要對策：

對策一：保屁大作戰-皮膚通氣照護標準化。

對策二：一定要護屁-IAD 評估工具資訊化。

對策三：指引個屁-增加攝入排出量跳出排便次數警示、系統開立醫囑時出現排便用藥決策支援。

對策四：就是愛臭屁-IAD 年度教育訓練計畫納入學習歷程(含案例分析與擬真教案)。

參、對策行動過程：

對策一：實測市售各款紙尿布及智能感濕機之尿布顯示功能、建立尿布選材指引及紙尿布穿著標準技術。

對策二：實證結果設計 IAD 嚴重度分級評估工具與照護指南，並完成團隊認知一致性與資訊化導入。

對策三：依實證結果建置重症病人瀉劑/止瀉劑處方建議與排便處置及照護指引，並導入每日排便次數警示資訊化與 IAD 床邊水蜜桃掛牌視覺提示。

對策四：規劃並推展各層級 IAD 照護能力進階制度與教案，提升團隊 IAD 評估認知的正確性與一致性。

肆、成果表現：

一、效果確認

1.失禁性皮膚炎發生率：

2018 年失禁性皮膚炎發生率改善前為 14.71%，介入措施後改善中 2019 年 10 月發生率 15.0%， 11 月發生率降至 7.46%，12 月發生率降至 6.25%(達目標值<7.35%)，2020 年 1 月續降至 4.48%。改善後 2020 年 2 月 3.77%，目標達成率 148.64%，進步率 74.37%。效果維持 2020 年 3 月~9 月皆維持在目標值 7.35%以下。

2.失禁病人失禁性皮膚炎發生率：

2018 年失禁病人失禁性皮膚炎發生率改善前為 31.25%，經由措施介入後改善中 2019 年 10 月發生率 39.1%， 2019 年 11 月發生率降至 26.32%，12 月發生率降至 17.39%。2020 年 1 月則降至 13.64%。改善後 2020 年 2 月 11.11%(達目標值<12.90%)，目標達成率 166.86%，進步率 64.5%。效果維持 2020 年 3 月~9 月皆維持在目標值 12.90%以下。

二、延伸性效益

1.IAD 病人接受排泄物清潔時的疼痛指數（CPOT 分數）平均值：由 8 分降至 4 分。

2.IAD 平均照護天數由 9.12 減少至 5.76 天。

3.照護費用：每人每天平均減少 42+12.75+(32.13~53.55)+4,500=4,586.88～4,608.30 元。

(1)尿布：每人最少腹瀉 3 次/天×14 元/片＝42 元/人日。

(2)清潔：潔膚液（200 元/236ml）=0.85 元/ml×每次約 5ml×3 次/天＝12.75 元/人日。

(3)防護：不同護膚品(300~500 元/28g)=10.71~17.85 元/g×3 次/天＝32.13~53.55 元/人日。

(4)三班護理師薪資：減少 4,500 元/人日。

4.年效益＝IAD 人數 27/7×12≒47 人/年×3.36 天/人×費用 4,586.88～4,608.30 元≒724,360~727,743 元/人年。

三、無形成果

以雷達圖十分量表調查品管圈運作前後之想法，發現圈員在「QC 手法運用」及「團隊精神」方面有明顯提升。

伍、檢討：

本次品管活動的成功推展，新增三項作業標準：成人紙尿布選擇與穿著術、重症單位病人排便處置及照護指引(含加護病房常用瀉劑及止瀉劑之處方建議)、加護單位品質指標-失禁性皮膚炎照護指標；完成資訊化五項：緩瀉藥物每日極量管控、「中文版 IAD 嚴重度分級工具及照護指南」檔案連結、IAD 評估資訊系統、IAD 嚴重度分級工具及照護指南 APP、每日排便次數警示資訊化；發展出創新護病溝通輔助工具四項：紙尿布選擇醫病共享決策輔助工具、IAD 嚴重度分級工具及照護指南圖卡、IAD 嚴重度對應產品圖卡、水蜜桃照護(排便)掛牌，提供護病溝通輔助工具，家屬與同仁對輔助工具應用滿意度皆達 100%；發展 5 個 N 層級 IAD 教案及教育訓練計畫，運用創意擬真教學，提升學習樂趣，並平行推展至所有加護病房。此外尚有二個提案建議進行中，持續推展並將改善經驗推廣至體系內各加護病房，以及國內各級醫療院所，創造本院重症照護魅力品質。

壹、 醫院與圈的介紹

一、醫院介紹

本院創立於 1968 年，原名為「財團法人逢甲醫院」，2010 年 11 月更名為「奇美醫療財團法人奇美醫院」。目前急性病床共 889 床，總床數為 1,284 床，設有醫療科部、醫療中心、護理、醫技及教學研究部門共 39 個，行政部門共 13 個，醫務、院務相關委員會共 45 個，員工約 3,500 人。本院核心價值為「關懷、專業、效率」，秉持以病人為中心之精神，並以「發展優質特色醫療」、「研究創新，培育優質人才」、「精實流程，強化服務品質」和「靈活管理，永續經營」為目標，建構良好醫療品質、保障病人安全與維護病人權益之組織文化，促進民眾和同仁的健康，以成為「民眾最信賴的健康照護體系」。

二、圈的組成：

表一、圈員介紹

圈名：CEOs 二圈			圈成立日期：2019/4/1
圈長：李穎俐			輔導員：紀婉玉
所屬單位：護理部加護病房			
主要工作：			
單位	姓名	職稱	圈活動任務
護理部	李穎俐	護理部督導	綜理主導活動圈之各項事務，管理圈執行進度與方向，代表活動圈與上級主管溝通協調。
加護醫學部	楊俊杰	5CI 主治醫師	給予臨床相關照護具體建議以及臨床醫療端配合管圈介入措施的執行。
護理部/5CI	陳亭君	5CI 護理長	協助圈長進行圈活動進度的控制與跟催、臨床介入措施推動，與參與圈活動與會議記錄。
護理部/5CI	張庭碩	5CI 小組長	協助圈活動的召集、會議場地借用、臨床介入措施推動，與參與圈活動與會議記錄。
護理部/5CI	李姍珊	5CI 小組長	協助圈進行中之文件製作與管理，配合臨床介入措施推動，與參與圈活動與會議記錄。
護理部/5CI	朱麗雯	5CI 護理師	協助圈進行中之文件製作與管理，配合臨床介入措施推動，與參與圈活動與會議記錄。
護理部	莊玟玲	傷口護理師	提供 IAD 相關實證資料，給予執行期具體建議措施，參與圈活動與會議記錄。
護理部	黃文佩	傷口護理師	提供 IAD 相關實證資料，給予執行期具體建議措施，參與圈活動與會議記錄。
護理部	鐘麗芬	品管護理師	協助圈活動各步驟之品管工具應用，與作業標準擬定，參與圈活動與會議記錄。
藥劑部	邱婉君	藥師	協助彙整 IAD 相關用藥決策的指引，並提供臨床用藥照護建議參與品管圈活動與會議記錄。
活動期間：2019/4/1~2020/4/30			

(一)圈名意義：

「加護護理團隊」強調以關懷(Caring)為出發點、依循護理證據(Evidence)，組織(Organization)團隊及各類資源，提供重症病人及家屬適切的支持(Support)以及安全(Safe)、滿意(Satisfaction)的照護，發展出以病人為中心的「CEOs」照護理念。因加護護理團隊共有 6 個加護病房，此圈以 5C 內科加護病房為主，故命名為 CEOs 二圈，意旨第二個組圈之加護護理團隊。

(二)圈徽意義：

圈徽係以聽診器之形為概念，以「白色」線條描繪，象徵純潔、神聖、善良與信任，上層為「聽診器聽音部分」，藉由聽診器頭件處聆聽身體內的聲音，寓意團隊以關懷(Caring）為出發點，細聽病人及家屬的需求及聲音；中間為「聽診器傳導部分」，導管處以英文書寫體大寫字母「E」字型貫穿，說明臨床照護決策以實證證據(Evidence)為依據；末端為「聽診器拾音部分」，聽頭處以「O」字展現圓滿、團結之意，代表連結整合(Organization)醫療團隊實務，透過跨領域溝通協調，提供病人、家屬適切的支持照護。聽頭中心以英文書寫體小寫字母「s」呈現，說明我們貼心提供重症病人及家屬適切的支持(Support)以及安全(Safe)、滿意(Satisfaction)的照護；底層以「深藍色」為基礎，沉著冷靜給人理智的印象，為智慧、堅定的代表色，體現本團隊在緊湊的加護病房中，帶給病人及家屬一個冷靜、值得信任的團隊。

(三)圈活動特點：

本圈為首次組圈，由負責加護護理團隊、傷口護理及護理資訊之督導擔任圈長，負責橫向及縱向協調溝通，加護醫學部醫師為重症病人醫療之專家，臨床藥師熟悉各種藥物藥理學及臨床應用、5C 內科加護病房護理師熟悉重症病人護理照護知識與技能，傷口護理師為傷口皮膚護理之領域專家，品管護理師為熟悉品管手法之專家。本圈成員涵蓋護理主管、第一線臨床照護醫護人員、傷口皮膚照護及品管專家，成員間以跨領域專業的方式合作，期望藉由圈活動的運作推行，突破失禁性皮膚炎的照護現況。

(四)會議頻率：每月召開 1～2 次品管圈會議，每次 1～1.5 小時**(附件一)**

二、單位簡介：

(一)護理部：

本院護理部下設部長、副部長、督導、專員、護理長、副護理長、小組長、護理師及佐理員共約 1,538 人，護理部的核心價值為品質、效率、人性化，願景為成為最佳的護理服務部門及執業環境，引領護理議題，為護理專業做出貢獻。

(二)加護醫學部：

本院共有 5 個成人加護病房單位(intensive care unit,簡稱 ICU)，內科系 57 床，外科系 38 床總共 95 床。每個 ICU 均有專責重症專科主治醫師及住院醫師、專科護理師、高階護理師、護理人員、呼吸治療師、營養師、藥師及物理治療師等跨科部醫療團隊。

(三)5C 加護病房：

5C 加護病房為內科加護病房，平均佔床率 94.79%，全日護病比 1:1-1.5。主要收治敗血性休克、腸胃道出血、成人呼吸窘迫症候群等急重症病人。護理人力滿編為 53 位，現有護理長 1 位、副護理長 2 位、小組長 9 位、高階護理師 3 位及 37 位護理師，另有 3 位佐理員。

貳、 主題選定

一、主題選定過程：

圈員先以針對5C加護病房中近年來常見的病人安全議題進行主題發想(如表二)，經過提案者說明提案理由及現況後，圈員們充分討論交換意見，再由 9 位圈員各自依可行性、迫切性、圈能力、重要性等四個面向進行評價，採三段評價，關聯最強的給5分、最弱的給1分，圈員各自評價分數如表二。最後以得分最高的主題：「**提升加護病房病人失禁性皮膚炎之照護成效**」，但考量「照護成效」偏向成本效益，故將**題目修正為「提升內科加護病房病人失禁性皮膚炎之照護品質**」作為本期 QCC 主題。

表二、主題一覽表

評價項目 / 主題	可行性	迫切性	圈能力	重要性	得分	選定
降低加護病房呼吸器導致肺炎感染率	27	19	15	21	82	
提升加護病房病人失禁性皮膚炎之照護成效	**43**	**41**	**39**	**45**	**168**	★
降低加護病房 MDRO 發生率	29	21	27	35	112	

評價說明	分/人	可行性	迫切性	圈能力	重要性
	1	次可行	次急迫	借助他人	次重要
	3	可行	急迫	部份需協助	重要
	5	極可行	極急迫	自行解決	極重要

(評分人數：9 人，分數為 9 人評分總和)　製表人：陳亭君製表日期：2019/04/12

二、活動主題

(一)主題名稱：**提升內科加護病房病人失禁性皮膚炎之照護品質**

(二)主題範圍：

1. 對象：以入住於 5C 加護病房之病人及失禁病人為收案對象。
2. 流程起迄：從入住本單位後收案，直到轉出加護病房後結案。

(三)專有名詞：

1. **失禁性皮膚炎 (Incontinence-associated dermatitis, IAD)**：指暴露於尿液或糞便造成的皮膚損傷反應(Black et al., 2011)。臨床症狀為紅斑、紅疹、浸潤、糜爛，甚至皮膚破損，可能伴隨著感染發生 (Gray et al., 2012)。本圈依文獻定義，將 IAD 嚴重分級為 1 級(發紅但皮膚完整)、2 級中度及 2 級重度者(發紅且皮膚破損)視為 IAD，納入指標定義之分子(Beeckman et al.,2015)。
2. **失禁病人：**包含有大便或小便失禁症狀的病人。大便失禁是指不自主地排出固體及液體的糞便(Robson, 2018)。而小便失禁是指任何不受控制的尿液洩漏(Clemens, 2019)。
3. **失禁性皮膚炎照護品質：**八成以上重症病人入院後，因病情變化而發生失禁(徐、許、章、鍾、徐，2013;)。IAD 的預防與照護是重症護理的重大挑戰，尤其是失禁的病人。一般來說，IAD 發生率最能充分反應出失禁性皮膚炎的照護品質(Bliss et al., 2011)。一般病人 IAD 發生率的改善或許與護理照護行為較為相關，但失禁病人的 IAD 發生率的改善，則需要醫療團隊通力合作才能見效。

4. **發生率**：指一定時期內的特定人群，新發生某一疾病的比率，IAD 發生率乃指過去一段時間內新發生的 IAD 人數比率(Beeckman et al., 2015)。5CICU 為屬內科加護病房，收治病人大多屬於 IAD 的高危險群，故 IAD 發生率一直是單位品管指標之一，護理師依護理部標準提供 IAD 照護措施。但回顧 2018 年本單位 IAD 發生率為 1.72%~4.55%。文獻查證得知台灣 IAD 發生率約落在 34.60(李、林，2015)~37.40%(莊、禹，2016)間，國外落在 18.84(Gupta et al., 2017)~65.40%(Wei, Bao, Chai, Zheng, & Xu, 2019) 間**(附件二)**。因數據差異大，在對主題深入討論後，發現本單位的發生率計算公式與其他國內外文獻定義不同**(附件二)**，無法直接比較。故參考文獻後重新定義 IAD 發生率計算公式如下：

(1)**失禁性皮膚炎發生率(李、林，2015)**：

$$\frac{\text{當月失禁性皮膚炎發生人數}}{\text{當月住院病人總人數}} \times 100\%$$

(2)**失禁病人失禁性皮膚炎發生率(Wei et al., 2019; Wang et al., 2018; Valls-Matarín et al., 2017; Zhou et al., 2017)**：

$$\frac{\text{當月失禁病人失禁性皮膚炎發生人數}}{\text{當月住院之失禁病人總人數}} \times 100\%$$

三、選題理由：

(一)**對病人而言**：降低失禁性皮膚炎病人接受排泄物清潔時的疼痛指數(CPOT 分數)。

(二)**對同仁而言**：降低護理人員皮膚護理時數。

(三)**對院方而言**：降低因失禁性皮膚炎期間醫療成本(天數、尿布費用)。

四、文獻查證：

(一)**失禁性皮膚炎之重要性：**

IAD 易伴隨感染與壓力性損傷(Pressure injury, PIs)的發生(Campbell, Coyer, & Osborne, 2016;Campbell et al., 2016)，進而延長住院天數、增加皮膚清潔及照護成本的支出(Bliss, Zehrer, Savik, Smith, & Hedblom, 2007)。因此 Bliss 等人認為 IAD 發生率最能夠反應出護理的照護品質，也與病人安全有關(Bliss et al., 2011)。

(二)**提升失禁性皮膚炎照護品質的要素：**

「失禁性皮膚炎現況分析」之掌握項目說明，係依據相關文獻之探討與單位的臨床現況分析後，歸類為評估（Assessment）、通氣(Air-Microclimate)、保護屏障(Barrier)、病況(Condition)、藥物(Drug)、組織環境(Environment)，逐一說明如下：

1. Assessment－認知評估

評估泛指醫療團隊對 IAD 評估知能的正確性、IAD 照護行為的正確性，以及評估工具的可近性等，包含：

(1)醫療團隊評估認知：研究顯示在加護病房有超過 60%的護理人員，無法區別 IAD 與 PIs (Pather & Hines 2016)， IAD 常被誤判

為 PIs (Beeckman et al., 2015)。然而 IAD 與 PIs 的照護措施不同，錯誤的照護方式將導致IAD或PIs嚴重，浪費不必要的醫療資源。

(2)醫療團隊照護行為的正確性：目前 IAD 的照護常見問題為評估不正確、對產品瞭解不足與使用不當(Kottner, Boronat, Blume-Peytavi, Lahmann, & Suhr, 2015)。例如未使用皮膚保護用品(趙、李、黃、尹，2016) 、使用肥皂/水和毛巾清潔(Beeckman, Verhaeghe, Defloor, Schoonhoven, & Vanderwee, 2011) 、清潔過程過度擦拭（徐等，2013）、未頻繁的更換失禁產品或清潔不足，而使皮膚長時間暴露於尿意和糞便中(Beeckman et al., 2015)，都會使病人 IAD 的風險加重。

(3)IAD 評估工具：分為風險評估量表與嚴重度評估量表。即使國外已經發展多種 IAD 的評估工具，但是大多數的評估量表因缺乏中文版或信效度，故未於臨床廣泛使用(Bliss et al., 2018; Van den Bussche, Verhaeghe, Hecke, & Beeckman, 2018)。再者有些工具過於複雜，恐增加臨床照護者的負擔。2015 年由全球 IAD 專家小組發表 IAD 嚴重分級工具 (Beeckman et al.,2015)，如圖一。可用於 IAD 損傷嚴重程度分級，適合與照護方案結合應用，並可用於品質監測。其優點在於圖文並茂簡單易懂，對於醫療文件的記錄，臨床決策和研究等方面都能有所幫助(Beeckman, 2017)，工具有良好的信效度(施洁，2017)。

臨床表現	IAD嚴重度	跡象**
	皮膚完整且無發紅（但有IAD的風險）	與其他身體部位相較之下，皮膚是正常的（沒有IAD的跡象）
	第一級－發紅*但皮膚完整（輕度）	發紅 +/-水腫
 中度　重度	第二級－發紅*且皮膚破損（中至重度）	同第一級 +/-小水泡／大水泡／皮膚潰爛 +/-皮膚剝脫 +/-皮膚感染

* 對膚色較深的患者，局部受損皮膚顏色可能變淺、變深、紫色、深紅色或黃色。
**若患者沒有失禁，則不屬於IAD。

CMH-Dr 網際網路存檔

圖一、IAD 嚴重分級工具

2. Air-Microclimate－通氣—微氣候管理

如果病人已有 IAD，需避免看護墊與尿布多層使用(李、林，2015)。選擇透氣、吸水力高、不回滲及聚合物材質之拋棄式尿布雖比可重複使用的尿布貴，但 IAD 的發生與皮膚受損的情況較少(林、許、楊，2016)。

3. Barrier－保護屏障

IAD 的照護包含清潔、保護及修復，採用結構式組合的皮膚防護方案，結合溫和的皮膚清潔和隔離防護產品的使用，依嚴重等級的不同給予不同的照護措施，可有效減少 IAD 的發生(Beeckman et al., 2015；許、林、陳，2016)。

(1)皮膚清潔：應採接近皮膚 PH 值的洗潔劑為佳，較能維持皮膚的

健康、改善皮膚破損，以及減少惡化(Cooper & Gray, 2001)。

(2)隔離防護：長效護膚霜能降低失禁導致的皮膚發紅(Williams, 2001)，而氧化鋅或保護膜噴劑均能夠改善 IAD，其中以保護膜噴劑的效果較好(Baatenburg de Jong & Admiraal, 2004)。

4. Condition－病人狀況

泛指加重病人 IAD 發生率的危險因子，包含：

(1)疾病因素：體溫過高、低氧合 (Bliss, et al., 2017)、疾病嚴重度高 (Beeckman, 2017)、糖尿病病史 (Kottner, Blume-Peytavi, Lohrmann, &Halfens, 2014)。

(2)營養狀態：低白蛋白<2.5g/dl(趙等，2016)、管灌飲食、肥胖 BMI≧27(徐等，2013)、年齡(>75 歲) (Kottner, Lichterfeld, & Blume-Peytavi, 2013)。

(3)活動限制：制動/約束(Beeckman, 2017)。

5. Drug－藥物

軟便劑、瀉劑及利尿劑均會造成病人大小便失禁，類固醇和免疫抑制劑會使皮膚變薄降低保護力，加上作用機轉不明的抗生素也是 IAD 的危險因子(Beeckman, 2017; Bliss, et al., 2017;徐等，2013)。

6. Environment－組織環境

組織病人安全文化是影響病人安全的重要因素，建立完善的 IAD 照護標準，每兩小時的密集性護理，可增進重症照護品質(林采蓉等，2015；林、許、張、楊，2016)。

五、QC STORY 判定表

以 QC STORY 判定表判定本活動將以課題達成型 QCC 進行(表三)：

表三、QC STORY 判定表

課題達成型	關係程度		問題解決型
1. 以前未曾有過經驗，首次面臨的工作欲順利完成（新規業務的因應）	33	41	1. 欲解決原來已在實施的工作中之問題。
2. 欲大幅度打破現況（現況打破）	45	33	2. 欲維持、提升現況水準。
3. 欲挑戰魅力的品質，魅力性水準（魅力性品質的創造）	41	35	3. 欲確保當然品質、當然水準。
4. 欲提前對應可預見的課題。	45	33	4. 欲防止再發生已出現的問題。
5. 透過方案、idea 的追究與實施可達成標的。	43	31	5. 透過問題的原因究明與消除原因，可獲得解決。
判定結果	合計分數		判定結果
★	207	173	

(關係程度（三段評價）：強關聯=5；關聯=3；次關聯=1，圈員評分人數：9 人)

製表人：陳亭君 製表日期：2019/04/12

參、活動計畫擬訂

依課題達成型步驟擬定此次活動計畫如表五，並依序進行。

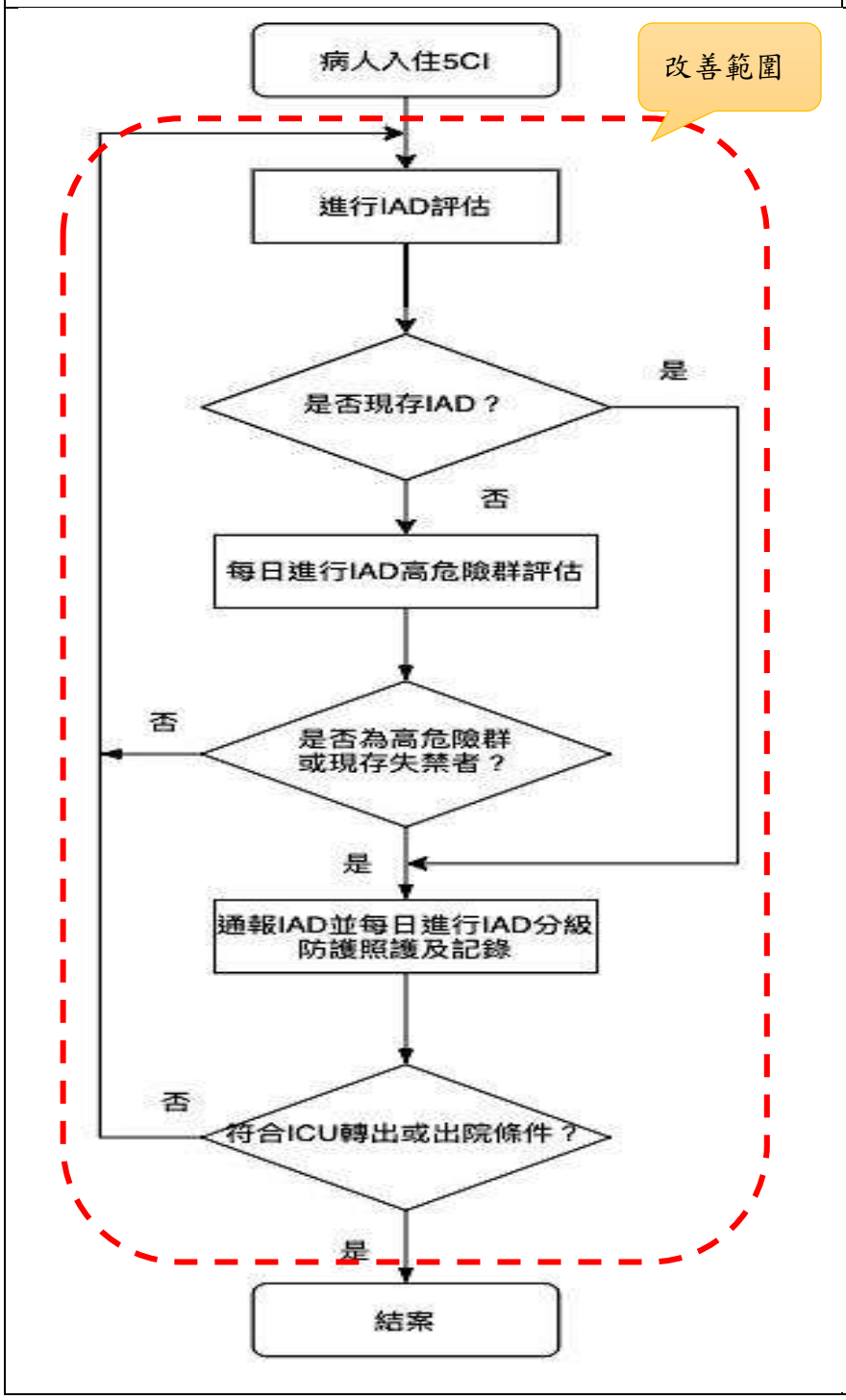
表五、活動計劃進度表

| WHAT | WHEN | | |

肆、 課題明確化：

一、作業流程簡介：

加護病房病人因病況因素，常為失禁性皮膚炎之高風險族群，因此5CICU 已將 IAD 發生率列入單位品管指標，並每月監測，且護理部訂有 IAD 照護標準，現行本單位作業流程如下圖二：

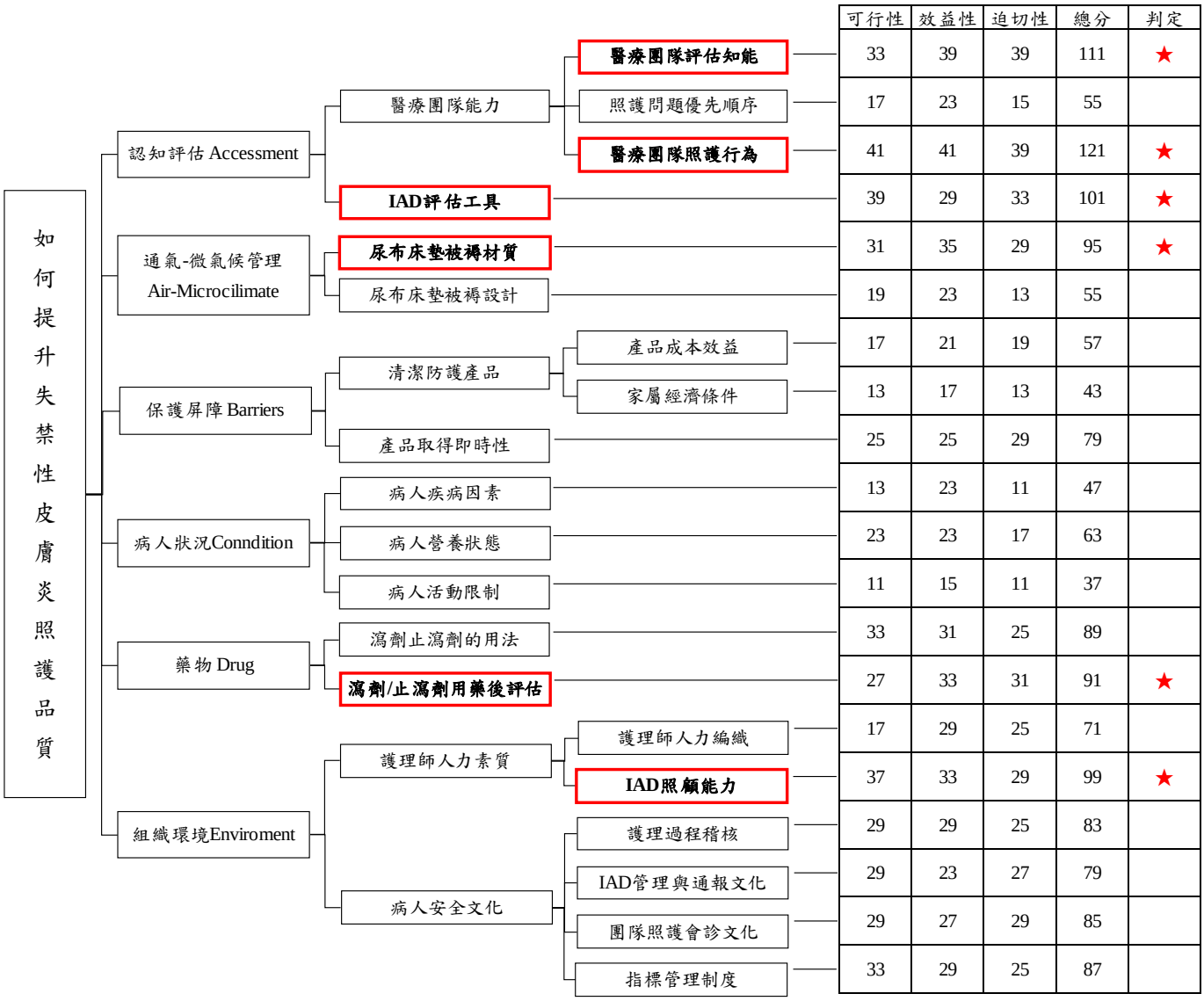
圖二、作業流程(流程圖)	作業內容說明
	**收案及結案：**入住本單位後即符合分母定義納入收案， IAD 嚴重度(含)1 級以上者即符合分子定義，直到個案轉出加護病房後結案。 **進行 IAD 評估：**入住本單位後進行首次評估，往後每次更換尿布及每兩小時進行 IAD 評估。 **每日進行 IAD 高危險群評估：**護理師每班至少主動進行一次 IAD 高危險群評估，如班內病情變化，則隨時留意是否出現高危險因子。 **通報 IAD 並每日進行 IAD 分級照護與紀錄：**護理師每次更換尿布及每兩小時進行 IAD 評估，並依 IAD 嚴重度分級採行對應的防護照護與記錄。如為 IAD 嚴重度(含)1 級以上者，需同步進行 IAD 通報，以利每月指標統計。

製圖人:張庭碩、陳亭君 製圖日期 2019/5/15

二、掌握項目說明：

參考上述文獻查證之結果，以及圈員對臨床護理人員照護現況的調查，歸納出以下分類：認知評估(Assessment)、通氣－微氣候管理(Air-Microclimate)、保護屏障(Barrier)、病人狀況(Condition)、藥物(Drug)，以及組織環境(Environment)，以 ABCDE 組合式照護的架構，運用系統圖法依序討論並展開掌握項目。接著以決策矩陣圖法依可行性、效益性、迫切性三個面向採三段式評價法(強關聯 5 分；關聯 3 分；次關聯 1 分)，由 9 位圈員進行評價，彙整分數如下表，評分後依 80/20 法則選定前 4 項目(共 20 項 x 20% = 約 4 項)。由於本圈期望能有效突破現況，故經圈員共識後再增加 2 項目，總計共 6 項掌握項目。

分析與判定結果如下**圖三**：



可行性	效益性	迫切性	總分	判定
33	39	39	111	★
17	23	15	55	
41	41	39	121	★
39	29	33	101	★
31	35	29	95	★
19	23	13	55	
17	21	19	57	
13	17	13	43	
25	25	29	79	
13	23	11	47	
23	23	17	63	
11	15	11	37	
33	31	25	89	
27	33	31	91	★
17	29	25	71	
37	33	29	99	★
29	29	25	83	
29	23	27	79	
29	27	29	85	
33	29	25	87	

圖三、掌握項目系統矩陣圖

製表人：鐘麗芬 製表日期：2019/5/30

三、攻堅點選定表

確認掌握項目後，圈員搜尋了 Cochrane、DynaMed Plus、ClinicalKey、Pubmed、CINAHL Plus with Full Text、Trip、及華藝資料庫，以關鍵字：加護病房、重症病房、失禁性皮膚炎、發生率(Intensive Care Unit, ICU、incontinence-associated dermatitis ,IAD、Incidence)、限定 5 年內、英文，搜尋到 203 篇文獻，刪除重複與不相關的文章 193 篇，共 10 篇實證文獻（**附件二**）。參考實證結果擬定本活動之期望水準、望差值及候選攻堅點(表六)。

表六、攻堅點選定表

課題特性	期望水準	現況水準
失禁性皮膚炎發生率	降至 7.35%	14.7%
失禁病人失禁性皮膚炎發生率	降至 12.90%	31.25%

課題	掌握項目	期望水準	現況水準	望差值	攻堅點(候選)	評價項目：消除望差的可能性	評價項目：工作場所的因應力	評價項目：顧客的期望	總分	選定攻堅點
如何提升失禁性皮膚照護品質	醫療團隊照護行為	醫療團隊成員能正確遵循符合最佳實證建議之 IAD 照護行為	醫療團隊成員現行之 IAD 照護方式未符合最佳實證建議照護模式	醫療團隊成員缺乏符合最佳實證建議之 IAD 照護模式	提升教育訓練學習成效	19	27	15	61	
					促進正確的 IAD 照護行為	37	27	39	103	★
					促進正確的照護判斷	27	27	27	81	
	醫療團隊評估認知	醫療團隊成員對 IAD 評估認知正確且一致	醫療團隊成員對 IAD 評估認知偏誤且不一致	醫療團隊成員對 IAD 評估認知的正確性與一致性不佳	提升教育訓練學習成效	25	27	23	75	
					促進醫療團隊 IAD 評估的信效度	31	33	41	105	★
					新增床邊教學	21	27	19	67	
	IAD 評估工具	推行符合最佳實證建議且適合臨床應用的 IAD 評估工具	現有 IAD 評估工具未符合最佳實證建議	缺乏符合實證建議且適合臨床應用的 IAD 評估工具	新增合適的 IAD 評估量表	31	31	23	85	
					新增適用的 IAD 評估工具	35	35	31	101	★
					發展本土化量表	15	13	29	57	
	尿布床墊被褥材質	尿布、床墊、被褥材質透氣及吸水性俱佳，且能妥善使用	尿布、床墊、被褥材質不透氣及吸水性不佳，未能妥善使用	缺乏透氣及具吸水性材質的尿布、床墊、被褥，及妥善的使用方式	促進優質尿布床墊被褥的使用	29	27	27	83	
					管理皮膚週邊微氣候	31	29	33	93	★
					新增開放式照護	27	25	19	71	
	IAD 照護能力	推行團隊 IAD 照護能力訓練計畫	無團隊 IAD 照護能力訓練計畫	缺乏團隊 IAD 照護能力訓練計畫	**增列年度教育訓練計畫**	35	37	35	107	★
					增列 N 層級護理能力要求	29	31	29	89	
					新增多元化學習平台	9	13	17	39	
	瀉劑、止瀉劑用藥後的評估	推行符合最佳實證建議之瀉劑、止瀉劑用藥後的評估及處置指引	沒有瀉劑、止瀉劑用藥後的評估及處置指引	缺乏符合最佳實證建議之瀉劑、止瀉劑用藥後評估及處置指引	**促進導致腹瀉用藥及排便之監測**	35	43	35	113	★
					降低因用藥致病人大小便失禁的發生	31	27	33	91	
					提升照護者評估	9	15	9	33	

(三段式評價：強關聯=5 分；關聯=3 分；次關聯=1 分；評分人數：9 人。)

製表人：李穎俐、鐘麗芬 製表日期：2019/5/30

(一)攻堅點選定結果說明

在攻堅點選定上，我們依掌握項目中的(醫療團隊照護行為、醫療團隊評估認知、IAD 評估工具、尿布床墊被褥材質、IAD 照護能力、瀉劑/止瀉劑用藥後的評估)展開候選攻堅點，並以決策矩陣圖法依消除望差的可能性、工作場所的因應力、顧客的期望三個面向採三段式評價法(強關聯 5 分；中關聯 3 分；弱關聯 1 分)，由 9 位圈員進行評價，評分後依 80/20 法則選定前 4 項攻堅點(共 16 項 x 20% = 約 3～4 項)，並經圈員討論希望攻堅點可涵蓋所有選定之掌握項目，故選定共 6 項攻堅點(如表六)。

(二)期望水準設定依據及現況水準說明

將各掌握項目之期望水準設定依據及現況水準說明整理如表七。

表七、期望水準設定依據及現況水準說明表

掌握項目	期望水準設定依據	現況水準說明
醫療團隊照護行為	依照目前部內各項過程面指標之通過標準設定應皆達執行「正確」，透過品質管制活動進行結構、過程、結果改善，期望促使醫療團隊成員 IAD 照護行為步驟皆能正確遵循實證建議執行	目前護理部雖訂有 IAD 護理技術，但文獻久未更新，醫療團隊成員現行之 IAD 照護方式未符合最佳實證建議照護模式，故無從判斷現行醫療團隊成員 IAD 照護行為正確率
醫療團隊評估認知	依照目前院內各項教育訓練認知性評估測試通過標準設定應皆達「正確」，故標竿院內品質標準，期望醫療團隊在 IAD 評估認知皆達「正確」	依本品管圈進行之實證文獻查證結果，設計 IAD 知能評估試題，測試執行單位所有護理師對 IAD 的評估及認知項目測試結果皆達「正確」僅有 4 位通過評核，通過率 8%(4/48)
IAD 評估工具	依本品管圈進行之實證文獻查證結果，IAD 評估工具相當多元，文獻建議評估工具應語言描述簡單易懂，圖文並茂，因此我們期望設計符合實證文獻建議的 IAD 評估工具	目前護理部使用之 IAD 評估量表未與時俱進地結合最佳實證建議的 IAD 評估工具，不利於臨床評估及指標管理
尿布床墊被褥材質	依本圈進行之實證文獻查證結果，皆建議應依病人的需求，提供透氣及吸水性俱佳的尿布床墊被褥，且能妥善使用	目前院內提供的尿布床墊被褥材質透氣性差，許多病人自備尿布，但有時自備尿布材質透氣、吸水性不佳，且護理師大多未能妥善使用尿布
IAD 照護能力	目前院內對各項重要照護能力皆設計相關教案或教育訓練計畫，故標竿院內品質標準，期望能設計規劃出可提升團隊 IAD 照護能力的訓練計畫	目前全院在 IAD 照護的訓練課程及能力要求上，皆無相關規範與討論
瀉劑、止瀉劑用藥後的評估	標竿院內品質標準，期望推行瀉劑、止瀉劑用藥後的評估及處置指引	以往用藥主要是由醫師決定，每位醫師的用藥喜好不同，沒有統一的瀉劑、止瀉劑用藥後的評估及處置指引

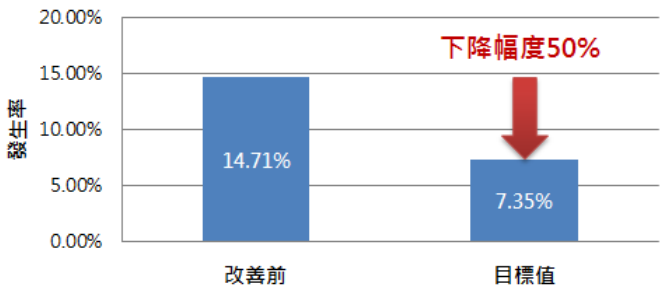
伍、 目標設定

一、目標值設定

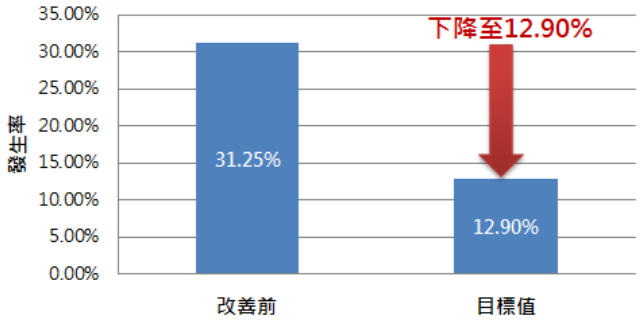
依據實證分析結果，照護品質目標設定為：

(一)失禁性皮膚炎發生率由 14.71% (98/666)下降至 7.35%。

(二)失禁病人失禁性皮膚炎發生率 31.25% (90/288)下降至 12.90%。



圖四、失禁性皮膚炎發生率



圖五、失禁病人失禁性皮膚炎發生率

二、設定依據

(一)失禁性皮膚炎發生率：

經文獻查證參考國內 2 家同等級醫學中心 IAD 改善研究，IAD 發生率為 A 院 37.40%降至 16.60%(莊、禹，2016)，改善幅度為 55.61%，及 B 院 34.72%降至 19.80%(林等，2015)，改善幅度 42.97%，取改善幅度平均值為 49.29%，取整數為 50%作為改善幅度，訂 IAD 發生率降為 14.7×50%=7.35%。

(二)失禁病人失禁性皮膚炎發生率：

依實證搜尋結果，以大小便失禁人數為分母的文獻共計五篇，發生率落於 12.90%～65.40% (詳見附件二)。因此採同儕標竿學習，挑戰最低發生率 12.90% (Zhou et al., 2017)，故目標設定為發生率由 31.25%下降至 12.90%。

陸、 方策擬訂：

選定攻堅點並設定目標後，由 9 位圈員腦力激盪將每個攻堅點進行二次方策展開，再以決策矩陣圖法依期待效果之重要性、創新性、效益性三個面向採五段式評價法(9 分、7 分、5 分、3 分、1 分)，評價後依 80/20 法則選定前 7 項(共 35 項 x 20% = 約 7 項)作為採行方策，方策效果評估表如表八。

然而攻堅點「促進正確的 IAD 照護行為」所有方策之期待效果皆非前 20%，因此未被選入。經評估 IAD 發生率為本單位既定指標，雖然原先的指標公式與新指標不同(見 P.4 發生率說明)，相關的指標管理機制已為本單位常規，故方策創新性分數較低，圈員共識即使未選入方策，仍可常規進行相關的品質管理作業(規範制訂、過程稽核、指標監控)，故此項非本次活動改善重點。

表八、方策效果評估表

攻堅點	方策	方策	期待效果			總分	選定方策
	一次展開	二次展開	重要性	創新性	效益性		
促進導致腹瀉用藥及排便之監測	增加導致腹瀉相關用藥處置提示	藥物資料庫中加入藥物提示註記	49	35	43	127	
		增加藥物天數與頻次(極量提示)	55	39	53	147	
	優化腹瀉用藥及排便次數性狀評估結果之監測與警示	設計腹瀉用較及排便次數性狀評估表單	35	25	27	87	
		增加攝入排出量跳出排便次數警示設定	57	53	55	165	★
	增加腹瀉病人用藥之支援決策	**系統開立醫囑時出現腹瀉用藥決策支援**	59	55	51	165	★
		腹瀉用藥protocol	53	49	59	161	
增列年度教育訓練計畫	依護理能力進階要求規範護理師於IAD照護能力之要求	擬定各層級進階時照護能力之要求	57	41	49	147	
		列入各層級必修課程之要求	47	37	55	139	
	依各層級護理師能力要求設計教育訓練計畫	**IAD教育訓練計畫納入學習歷程計畫**	63	63	63	189	★
		滿三個月護理人員基礎能力	59	35	55	149	
	依各訓練計劃之學習目的設計合適的教案	**擬真教學**	57	63	61	181	★
		床邊教學	55	41	61	157	
		案例研討	35	33	35	103	
促進正確的IAD照護行為	依實證建議修訂IAD照護標準	傷口護理師不定期依最新證據檢視修訂	47	41	45	133	
		作業標準組定期追蹤檢定修訂	51	33	43	127	
	擬定並執行IAD護理過程稽核計畫	定期稽核	47	29	49	125	
		不定期稽核	35	29	49	113	
	擬定並執行IAD護理指標計畫	擬定IAD護理過程指標	57	35	49	141	
		擬定住院病人IAD發生率指標	59	47	55	161	
		擬定高風險失禁性皮膚炎病人IAD發生率指標	61	53	59	161	
促進醫療團隊IAD評估的信效度	促進醫療團隊對對重症皮膚照護的認知	提供重症皮膚照護教育訓練	45	41	49	135	
		舉辦IAD照護工作坊，提升評估與照護的一致性	43	39	41	123	
	促進醫療團隊對評估內容共識	**案例討論**	55	61	57	173	★
		設計標準考題	43	37	27	107	
		定期測驗	41	29	35	105	
新增適用的IAD評估工具	依實證建議定期修訂IAD評估工具	傷口護理師不定期依最新證據檢視修訂	57	39	47	143	
		作業標準組定期追蹤檢定修訂	45	29	43	117	
	提升IAD評估工具的可近性	設計發展紙本IAD工具	35	43	41	119	
		IAD評估工具資訊化	71	67	69	207	★
管理皮膚週邊微氣候	提供有利於皮膚週邊微氣候管理的設備及衛材	尿布材質測試流程	33	41	37	111	
		進行各類尿布、看護墊材質測試	53	43	49	145	
		提供涼感式防水中單或床墊取代現有防水中單床單	45	63	47	155	
	研發皮膚週邊微氣候管理的照護方式	引流系統的介入措施	51	41	49	141	
		皮膚照護通氣照護標準化	65	43	67	175	★
		智慧尿溼感知器	41	57	41	139	

(五段式評價：9 分=極關聯、7 分=強關聯、5 分=關聯、3 分=次關聯、1 分=微關聯；團員投票人數：9 人，最高分：243 分，評價後選定總分前 20% (7/35)為採行方策)　製表人：張庭碩、黃文佩　製表日期：2019/6/15

柒、最適策追究（成功劇本追究）

一、預測障礙排除檢討追究：

為確保每個方策都能順利進行，同時預測及排除執行過程中的相關障礙及可能的副作用，經圈員討論後，整理預測障礙排除檢討追究表(如表九)，並判定七個方策皆可行。

表九、預測障礙排除檢討追究表

次序	方策	障礙的判定內容	消除障礙的作法	副作用	消除副作用的作法	判定
1	IAD 評估工具資訊化	1.找不到合適的中文版評估工具 2.合適工具未獲作者授權 3.等待資訊化時間過長	1.以實證手法找到中文版具信效度工具 2.與作者聯繫取得中文化授權 3.照會資訊室共同研討撰寫設計	1.尋找耗時 2.版權費用產生 3.排擠其他資訊化作業排程	1.進行前驅性研究 2.依順位選擇可使用工具 3.資訊化前先進行紙本 IAD 評估工具過渡期使用	○
2	IAD 教育訓練計畫納入學習歷程	1.課程多，影響上課意願 2.依賴影音學習只線上考試，不去課室教學	1.列入各層級年度必修課程 2.實作課程不開放影音教學	1.講師不足 2.實作課程教材教具需學經費	1.增加種子教師培訓 2.申請部內教育經費	○
3	擬真教學	缺乏合適擬真教具	尋找合適的擬真教具： 1.借用屁股模型作為擬真教具,加上彩妝，進行各項擬真教學。 2.於網路上搜尋各種模擬糞便的製作，製作各種擬真的糞便型態。	擬真教具無法重現病人皮膚狀況	至果菜市場找尋各式蔬果，測試出最接近失禁病人皮膚狀況的擬真教具。	○
4	皮膚通氣照護標準化	1.無尿布選擇之相關標準作業 2.病人使用紙尿布材質不一 3.家屬對衛材選擇與經濟考量 4.無尿布穿著及皮膚通氣照護之作業標準	1.收集市售各紙尿布品牌及價格,進行各項功能實測。 2.改善病人使用之紙尿布材質。 3.製作「紙尿布選擇醫病共享決策輔助工具」。 4.以實證手法制訂各項作業標準。	定期執行尿布通氣會增加照護時數	1.參考國內外文獻及他院照護經驗制定相關標準。 2.擬定人工智慧濕度感知器監測尿布通氣時機減少工時。	○
5	案例討論	團隊無法參加	指定時間	指定時間無合適個案	影音多媒體記錄個案狀況以供討論	○
6	增加攝入排出量跳出排便次數警示設定	等待資訊化時間過長	照會資訊室共同研討撰寫設計	排擠其他資訊化作業	每日 07:00-07:00 間解便>2 次或總計>200 克(達腹瀉定義)掛牌提醒	○
7	系統開立醫囑時出現腹瀉用藥決策支援	1.無腹瀉用藥相關 protocol、作業規範可依循 2.系統排程時間久	1.與醫療團隊依據臨床經驗制定指引 2.與相關藥委會及醫囑電腦化小組撰寫支援系統	部分醫師用藥經驗與 protocol 不符	1.與醫師和藥師共同討論合適的用藥指引，並在不造成醫師作業干擾下，建立用藥管控 2.由藥師於藥物檔案進行極量管控,不干擾醫師正常用藥行為 3.由藥師協助建利用腹瀉用藥指引供團隊依循	○

(判定評價：○：可、×：否)　　製表人：李姍珊、朱麗雯　　製表日期：2019/7/16

二、最適策具體化形成：

為落實每個方策，經圈員討論及共識後，逐一擬訂每個最適方策之執行時、地、方法及實施計畫(如表十)，且根據最適策內容對於提升 IAD 照護品質之影響程度由大至小進行最適策編號。

表十、最適策具體化形成表

為何	最適方策	人	時/時機	地/場所	方法	實施計畫	最適策編號	最適策名稱
提升內科加護病房病人失禁性皮膚炎之照護品質	1.IAD 評估工具資訊化	李穎俐 莊玟玲 黃文佩	7/22-8/14	5CICU	照會資訊室共同研討撰寫設計程式	1.搜尋國內外文獻取得合適中文版評估工具授權，完成內在一致性。 2.完成系統需求分析並照會資訊室共同研討撰寫設計。 3.資訊化前先製作紙本 IAD 評估工具試行以檢討改善。	二	一定要護屁
	2. IAD 教育訓練計畫納入學習歷程	陳亭君	8/14-9/8	5CICU	修訂學習歷程進階規範	1.依據各層級 IAD 照護應具備能力進行教學活動，並列入各層級能力進階規範。 2.研擬各層級 IAD 照護教案，舉辦在職教育，促進護理人員照護相關知識、技能及態度。 3.與教育訓練委員會商擬，依層級應具備 IAD 照護能力列入年度共通必修課程。	四	就是愛臭屁
	3.擬真教學	李姍珊 朱麗雯	7/22-9/8	5CICU 臨床技能中心	1.設計實作之擬真教案。 2.製作擬真教具，含假屁股和模擬各種型態假大便(成形便、水便、糊便等)。	1.設計擬真教案，購買及製作合適的擬真教具。 2.借用屁股模型進行彩妝，以利分辨不同 IAD 級數。 3.至市場購買大黃瓜模擬失禁病人皮膚狀態。 4.於網路上搜尋各種模擬糞便的製作，以瓦楞紙加芝麻醬，製作出各種擬真的糞便型態。 5.運用擬真教具進行實作之擬真教案。	四	
	4.案例討論	李姍珊 朱麗雯	7/22-9/8	5CICU	收集臨床 IAD 案例	邀請醫師、藥師、傷口護理師等醫療團隊進行案例討論，必要時錄製影片供討論。	四	
	5.皮膚通氣照護標準化	李姍珊 張庭碩 朱麗雯	7/22-9/8	5CICU	1.實證搜尋照護標準 2.購買智慧濕度感知器監測	1.收集市售各紙尿布品牌及價格，進行各項功能實測，並透過智能感濕機達到通氣提示。 2.改善病人使用之紙尿布材質。 3.製作「紙尿布選擇醫病共享決策輔助工具」。 4.以實證手法搜尋文獻制定各項作業標準	一	保屁大作戰
	6.增加攝入排出量跳出排便次數警示設定	鐘麗芬	9/2-10/15	5CICU	照會資訊委員會共同研討撰寫設計程式	1.提案護理資訊委員會，與資訊室合作撰寫排便次數警示程式。 2.資訊系統正式上線前，每日 07:00-07:00 間解便>2 次或總計>200 克(達腹瀉定義)予掛牌提醒。	三	指引個屁
	7.系統開立醫囑時出現腹瀉用藥決策支援	楊俊杰 李穎俐 鐘麗芬	7/22-9/8	5CICU	資訊委員會申請系統設定	1.邀請醫療團隊，共同依據藥理及臨床照護經驗設計腹瀉用藥及處置決策支援指引。 2.與藥委會及醫囑電腦化小組討論加入醫囑開立決策支援。	三	

製表人：李姍珊、朱麗雯、陳亭君　製表日期：2019/7/16

捌、最適策實施與檢討

最適策編號一	最適策名稱	保屁大作戰
	最適方策	皮膚通氣照護標準化
	掌握項目	尿布床墊被褥材質
	望差值	缺乏透氣及具吸水性材質的尿布、床墊、被褥，及妥善的使用方式

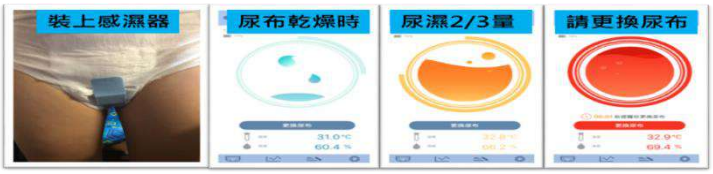
最適策內容(P)
負責人：張庭碩、鐘麗芬
預期實施期間：2019 年 9 月 1 日至 12 月 31 日　**預期實施地點：**5CICU
最適策實施計劃：
1.收集市售各紙尿布品牌及價格，進行各項功能實測，並透過智能感濕機達到通氣提示。
2. 整合紙尿布材質、規格、價格及功能，制定選材建議指引，並改善病人使用之紙尿布材質。
3. 以實證手法建立紙尿布選擇及正確穿著標準，並進行護理人員紙尿布選擇及正確穿著教學。

最適策實施(D)
負責人：張庭碩　　**改善對象：**尿布被褥材質
實施期間：2019 年 9 月 1 日至 12 月 31 日
實施地點：5C 加護病房
實施執行步驟：

1.**收集市售各紙尿布品牌及價格，進行各項功能實測，並透過智能感濕機達到通氣提示：**
1.1.於 2019/09/23 參訪尿布製造工廠，了解尿布製程、品質監控，及實驗過程(圖六)。
1.2.2019/09/30 搜集國內、國外成人紙尿布檢測標準，包含：ISO-15621(紙尿布吸收及穿戴檢測標準)、ISO-17190(失禁性尿液吸收品檢測標準)、經濟部標準檢驗局 CNS-13073 成人紙尿褲檢測標準，彙整出尿布檢測及選材四項要素：(1)表層 PH 值(2)透氣性(3)保留性(4)回滲性，納入內部實測重點。
1.3.2019/10/05~10/15 收集市面上各廠牌紙尿布產品及價格調查，依據經濟部 CNS-13073 檢測標準進行 13 項產品內部實測(圖七)。
1.4.2019/10/08 購入市售成人智慧濕度感知器，10/10~10/30 經圈員親身試用並實驗感濕器監測尿布溫度及濕度之提示功能。(圖八)

圖六、參訪南部尿布製作工廠，與各業務負責部門代表合影

圖七、依據 CNS-13073 檢測標準，進行紙尿布內部實測



圖八、經由 Opro9 感濕器實測，透過尿布滲濕警報提示更換尿布時機(照片經本人同意)

2.整合紙尿布材質、規格、價格及功能，制定選材建議指引，並改善病人使用之紙尿布材質：
2.1.2019/10/05~10/15 完成收集醫院周邊及賣場各廠牌紙尿布產品量販價格調查。
2.2.2019/11/1~11/12 搜尋微氣候管理相關文獻，結合紙尿布價格調查、內部實測結果，製成**紙尿布選擇醫病共享決策輔助工具(附件四)**，提供病家對紙尿布選擇決策輔助。
2.3.2019/12/4 提案建議引進不織布材質、回滲量低及柔膚性的產品提供臨床病人使用。(**附件五**)
2.4.2019/12/4 提案建議修訂「加護病房自購衛材清單」，將紙尿布單一選擇尺寸由 L-XL 修改為 S/M/L/XL，提供病家正確採買資訊。(**附件六**)

3. 以實證手法建立紙尿布選擇及正確穿著標準，並進行護理人員紙尿布選擇及正確穿著教學：
3.1.2019/9/28 晨間會議教導護理人員正確之尿布選擇及穿著認知及行為。
3.2.2019/11/11 圈員至佳里院區向曾接受過日本專家指導成人紙尿布穿著及大、小便排便處理與尿布選材課程之同仁標竿學習，自創尿布穿著口訣，並制定**成人紙尿布選擇及穿著護理術(附件七)**。
3.3.2019/11/12 ~13 共舉辦三場單位內紙尿布選擇及穿著講習與實物操作課程(圖九)。

圖九、透過真人及假屁股模型，執行紙尿布更換實物操作

最適策效果(C)

1.因智慧感濕器只對不織布材質有效，對 PE 材質紙尿布完全無法感濕，故圈員對使用不織布材質尿布個案共測試 6 人次，只有一次能及時於尿濕後 5 分鐘內發出替換尿布警示。其餘 5 人次在 30 度 C 以上，且濕度 65%以上的感知時間分別為 10 分鐘到 2 小時不等，感濕時間過長，即時性差，且對糞便的感知成效並未測得。2019/12/31 統計試用結果，共使用 6 人次，護理人員滿意度僅 30%。

2. 2019/12/1 正式啟用「紙尿布選擇醫病共享決策輔助工具」以提供病家對紙尿布耗材購買決策，12/31 追蹤採自購衛生用品的病家共 27 人，正確執行紙尿布選擇醫病共享決策輔助工具之人員共 18 人，完整率 67%，針對執行不完整之人員當下給予再教育，並於晨間會議再宣導，1 月追蹤完成率達 100%，家屬與同仁對工具應用滿意度皆達 100%。

3. 2019/12/1~12/10 追蹤護理人員執行尿布穿著正確稽核共 48 人，正確率未達 50%。於臨床教育後，109 年 1 月 15 日進行抽樣稽核 3 人，正確率 100%。

最適策處置(A)

1.因此次測試之智慧感濕器敏感度不佳，故不予列入此次對策實施，等市面上有其他敏感度較高的感濕器產品出現再進行測試。

2.「紙尿布選擇醫病共享決策輔助工具」使用成效佳，列入 5CICU 標準作業程序。

3.「成人紙尿布選擇及穿著護理術」列入三個月新進人員學習歷程中。

4.建議院方引進不織布材質、回滲量低及柔膚性的產品提供臨床病人使用之提案(附件五)，於 2020/1/30 完成各單位針對其一試用之尿布廠商 O 護成人紙尿褲與成人替換式尿片，並回覆資材試用結果，持續追蹤後續尿布廠商之商品試用

5.提案護理行政委員會建議修訂「加護病房自購衛材清單」將紙尿布單一選擇尺寸由 L-XL 修改為 S/M/L/XL 多元化提供病家正確採買資訊(附件六)，並續追蹤該清單修改鉛印編碼文件。

最適策編號二	最適策名稱	一定要護屁
	最適方策	IAD 評估工具資訊化
	掌握項目	IAD 評估工具
	望差值	缺乏符合實證建議且適合臨床應用的 IAD 評估工具

最適策內容(P)

負責人：莊玟玲、黃文佩

預期實施期間：2019 年 9 月 9 日至 12 月 31 日　　**預期實施地點：**5CICU

最適策實施計劃：

1.搜尋合適的 IAD 評估工具：搜尋國內外文獻取得合適中文版評估工具授權。

2.規劃 IAD 評估工具資訊化：製作 IAD 評估替代工具，並宣導、試行、改善，完成內在一致性。

3.進行 IAD 評估工具資訊化：進行系統需求分析並照會資訊室共同研討撰寫設計。

最適策實施(D)

負責人：莊玟玲　　**改善對象：**評估工具

實施期間：2019 年 9 月 17 日至 11 月 30 日　**實施地點：**5C 加護病房

實施執行步驟：

1. 搜尋合適的 IAD 評估工具：

1.1 搜尋國內外文獻找尋合適中文版評估工具，9/2 於傷口護理師會議中討論，確認採用 2015 年 IAD 專家制訂的**「中文版 IAD 嚴重度分級工具」(附件八)**。

1.2 9/5 與中英文版的作者聯繫取得授權。

1.3 由於 IAD 嚴重度分級工具與照護方案結合，能提供臨床實務的應用及品質監測(許、林、陳，2016)。故圈員進行系統性文獻回顧失禁性皮膚炎預防與處置相關文獻，統整為「IAD 嚴重度分級工具及照護指南」，內容包含 IAD 的評估與各等級之照護處置。

2.規劃 IAD 評估工具資訊化：製作 IAD 評估替代工具並宣導、試行、改善，完成內在一致性

2.1 10/18 完成「IAD 嚴重度分級工具及照護指南」檔案製作。

2.2 10/24 印製「IAD 嚴重度分級工具及照護指南」，11/17 於單位宣導並設置每台護理工作車一張圖卡，方便臨床照護使用(圖十)。

2.3 10/24 收集市售 IAD 清潔保護產品及售價，10/25 完成 IAD 嚴重度對應產品圖卡，設於護理站供人員與病家參考(圖十一、附件九)

2.4 10/28 護理資訊委員會會議通過於護理資訊系統中增加「中文版 IAD 嚴重分級工具及照護指南」（附件十）檔案連結，路徑為：護囑系統→護理評估→管路皮膚約束評估→失禁皮膚照護。

2.511/12 10:00-10:40、11/13 15:00-15:30、17:00-17:30，進行單位「中文版 IAD 嚴重度分級工具及照護指南」的宣導與教育(圖十二)

圖十、護理工作車設置 IAD 嚴重度分級工具及照護指南圖卡

圖十一、護理站設置 IAD 嚴重度對應產品圖卡

圖十二、重症單位病人失禁傷口評估及照護上課照片

2.6 11/21 依臨床使用的建議，修改「IAD 嚴重度分級工具及照護指南」。
2.7 11/26 宣導修改版「IAD 嚴重度分級工具及照護指南」，並申請於皮膚評估系統增加檔案連結。
2.8 2019/11/30 與長榮大學資訊設計系學生合作研發「IAD 嚴重度分級工具及照護指南」APP。

3. 進行 IAD 評估工具資訊化：進行系統需求分析並照會資訊室共同研討撰寫設計

3.1 10/14 與資訊護理師一起討論 IAD 評估系統需求分析與介面設計規劃。
3.2 10/18 作業標準委員會審核通過於護理資訊系統「傷口評估」中加入 IAD 評估內容。

最適策效果(C)

1.搜尋合適的 IAD 評估工具：10/11 取得 IAD 嚴重度分級工具授權。

2.規劃 IAD 評估工具資訊化：

2.1 11/12-13 教育訓練，總計 26 位護理人員參與，執行工具簡介與 IAD 嚴重度的評估教學後，即時進行評量，於評估表的平均答對率為 96%。
2.2 2019/11/17-2019/11/20 完成 48 位人員對中文版 IAD 嚴重分級工具及照護指南之意見調查，回收率達 94 %。認為有助於適當照護：25 人、有助分級鑑別：19 人、操作方便：7 人、非常棒：5 人、無意見：5 人、提供即時照護：4 人、提供一致照護：2 人。
2.311/26 完成 48 位人員之自學與後測，後測成績平均 96 分。
2.412/31 資訊室協助完成「中文版 IAD 嚴重度分級工具及照護指南」檔案連結。
2.5 2020/01/22 長榮學生完成「IAD 嚴重度分級工具及照護指南」APP 開發**(附件十一)**

3.進行 IAD 評估工具資訊化：2020/03/25 資訊室完成 IAD 評估系統上線。

4.完成 IAD 評估系統導入：2020/04/07 完成 IAD 評估教學影片及線上考題，上傳至「影音講座」系統供單位人員自學並線上測驗 100 分才通過，通過率 100%，4/13 5CI 正式啟用 IAD 評估系統。

最適策處置(A)

1.將 IAD 評估系統、中文版 IAD 嚴重分級工具及照護指南列入 5CICU 常規應用。
2.將 IAD 嚴重度分級工具及照護指南圖卡置於護理行動車上，檔案連結至「管路皮膚約束評估系統」上，並將設計之「IAD 嚴重度分級工具及照護指南」APP 供人員自學、應用。

最適策編號三	最適策名稱	指引個屁
	最適方策	**1.增加攝入排出量跳出排便次數警示設定** **2.系統開立醫囑時出現腹瀉用藥決策支援**
	掌握項目	瀉劑、止瀉劑用藥後的評估
	望差值	缺乏符合最佳實證建議之瀉劑/止瀉劑用藥後評估及處置指引

最適策內容(P)

負責人：5CI 楊俊杰醫師、李穎俐督導、鐘麗芬護理師、邱婉君藥師(10/1 加入)
邀請圈友：趙苔君營養師
預期實施期間：2019 年 9 月 1 日至 12 月 31 日　**預期實施地點：**5CICU
最適策實施計劃：
1.建置重症單位病人排便處置及照護指引。
2.建置每日排便次數資訊提示機制。

最適策實施(D)

負責人：鐘麗芬　　**改善對象：**5CICU 醫療團隊
實施期間：2019 年 9 月 1 日至 12 月 31 日　　**實施地點：**5CICU
實施執行步驟：

1. 建置重症單位病人排便處置及照護指引：

1.1.9/20 邀請營養師參與團隊討論、10/1 因最適策推展需要師協助，故正式邀請藥師加入團隊。
1.2.10/15~10/20 進行系統性文獻查證，擬定**重症單位病人排便處置及照護指引**。
1.3.10/15~10/25 由藥師彙整現有輕瀉劑與止瀉藥處方，整理加護病房常用瀉劑 (Laxatives agent)及加護病房常用止瀉劑 (Antidiarrheal agent)之處方建議。
1.4.11/20 與醫師、藥師討論提示機制，決議由藥師提案藥劑部設定瀉劑、止瀉劑每日極量管控。
1.5.11/12~13 分別舉辦三場重症單位病人排便處置及照護指引說明會(圖十三)。
1.6.12/6 16:00-16:30 召開臨床會議，向單位人員、專科護理師說明重症單位病人排便處置及照護指引運作方式，並於護理站張貼看板(圖十四)。

圖十三、舉辦重症單位病人排便處置及照護指引、排便用藥建議說明會

圖十四、臨床會議、單位張貼重症單位病人排便處置及照護指引看板，方便臨床使用

2.建置每日排便次數提示機制：

2.1 2019/11/11 完成水蜜桃照護(排便)掛牌製作，舉辦每日排便輸出量及次數警示掛牌使用原則說明及納入交班項目，於 11/25 於單位正式開始，凡解便每日 3 次以上(即第 4 次)或每日超過 200 克之病人，須掛上水蜜桃照護掛牌(圖十五)。

圖十五、水蜜桃照護掛牌置放病人床頭，提示 IAD 高危險族群

2.2 2019/12/12 於加護科系單位科會中，針對排便次數自動提示資訊化提案討論通過，續於 2019/12/13 正式提案至護理部作業標準及護理資訊委員會討論（附件十二）。

最適策效果(C)

1. 11/18 完成重症單位病人排便處置及照護指引、加護病房常用瀉劑 (Laxatives agent)及止瀉劑(Antidiarrheal agent)指引共一項**(附件十三)**。
2. 11/24 完成於醫囑系統設定瀉劑、止瀉劑藥物每日極量管控(圖十六)。

圖十六、設定瀉劑、止瀉劑藥物每日極量管控

3. 12/10 測驗 52 位含醫師、專師、護理師，醫(護)人員之重症單位病人排便處置及照護指引認知及排便型態、次數評估認知正確性，正確率達 100%。
4. 12/10~2020/1/9 稽核團隊針對每日排便次數、克數超出腹瀉建議範圍時執行水蜜桃照護(排便)提示掛牌的正確性，正確率達 100%。
5. 12/10~2020/1/9 稽核團隊醫囑開立瀉劑、止瀉劑及緩瀉藥物正確評估率皆達 100%。
6. 12/20 再追蹤重症單位病人排便處置及照護指引使用成效，醫(護)人員共計 25 人認知度及排便型態、次數評估認知正確性達 84%，認知不正確 4 人，當下再認知教學，12/27 再追蹤正確性達 100%。
7. 12/28 再追蹤醫囑開立瀉劑、止瀉劑使用正確率 100%。
8. 2020 年 1 月份因改善失禁病人失禁性皮膚炎發生率未達閾值(13.64%>12.90%)。經團員再次釐清腹瀉定義，修訂並重新宣導水蜜桃照護掛牌時機改為每日第 3 次解便或每日解便總量超過 200 克之病人，並針對資訊系統提案內容提出修正，於 2020 年 2 月份護理作業標準委員會再次提出討論，但三院區無法達成共識，改提三院區部長會議討論。

最適策處置(A)

1.將重症單位病人排便處置及照護指引、加護病房常用瀉劑及止瀉劑指引列入 5CICU 標準作業程序。瀉劑、止瀉劑藥物每日極量管控平行推展至三院區醫囑資訊系統。

2.於 2020/02/01 起，於本單位全面將提示動作提前至每日第 3 次解便或每日解便總量超過 200 克之病人，即須掛上水蜜桃照護掛牌。

3. 2020/04/29 三院區部長會議通過，永康及佳里院區 ICU 每日排便次數、克數超出腹瀉建議範圍(每日第 3 次解便或每日解便總量超過 200 克)時，TPR 紀錄系統可呈現一次提示，已於 2020/07/29 公告上線。

最適策編號四	最適策名稱	就是愛臭屁
	最適方策	1.IAD 教育訓練計畫納入學習歷程 2.擬真教學 3.案例討論
	掌握項目	IAD 照護能力、醫療團隊評估認知
	望差值	1.缺乏團隊 IAD 照護能力訓練計畫 2.醫療團隊成員對 IAD 評估認知的正確性與一致性不佳

最適策內容(P)

負責人：陳亭君、莊玟玲、黃文佩、朱麗雯、李姍珊

預期實施期間：2019 年 8 月 14 日至 12 月 31 日　　**預期實施地點：**5CICU

最適策實施計劃：1.規劃各層級 IAD 照護能力進階課程與教案。2.提升護理人員 IAD 照護知能。3.將 IAD 教育訓練納入能力進階。

最適策實施(D)

負責人：陳亭君 **改善對象：**護理人員 **實施期間：**2019 年 8 月 15 日至 12 月 31 日 **實施地點：**5CI

實施執行步驟：

1　規劃各層級 IAD 照護能力進階課程與教案：

1.1 8/15~ 11/5 制定各層級教學大綱，由傷口護理師設計各層級 IAD 照護教案**(附件十四)**。

1.2 10/29 修訂專業能力進階規範。

2　**提升護理人員 IAD 照護知能：**

2.1 N、N1、N2 先進行前測後，採線上自學，完成後再行後測。

2.2 舉辦 N3 在職教育課室課程三堂:11/12 09:00-10:00、11/13 14:30-15:30、11/13 16:30-17:30，課程認證未通過者，11/20-11/30 由朱麗雯協助一對一補學，並完成前後測。課室採擬真教學，含擬真糞便與模擬排便後實境清潔教學(圖十七)，提供人員參與正確清潔糞便的正確技能。

圖十七、擬真糞便（材料：牛皮紙、水、芝麻醬）、模擬排便後實敬清潔教學

3　將 IAD 教育訓練納入能力進階：

3.1　於 11/30 課程評值後，將 IAD 相關課程列入單位能力進階計畫。

3.2　計劃須由傷口護理師每年檢視 IAD 新知，協助檢視能力進階計畫之修訂與 N3 以上課室教學及 N4 種子教師培訓（包括擬真教學與實作測驗）。

最適策效果(C)

1. 完成各層級 IAD 照護能力進階課程與教案：各層級須具備知識技能為，N：IAD 預防性照護(1 小時)、N1：IAD 評估與處置(1 小時)、N2：判別 PI 與 IAD(1 小時)、N3：IAD 困難照護(1 小時)、N4：種子教師(1 小時)（教案如附件十四）。
2. 完成 N-N2 在職教育，前測平均分數：N:53.3 分、N1:71.2 分、N2:48 分；後測 N:80 分、N1:80.8 分、N2:70 分。
3. 完成 N3 在職教育課室課程三堂:11/12 09:00-10:00、11/13 14:30-15:30、11/13 16:30-17:30，出席率：86.4%(含 N4 人員) 。前測平均分數：62，後測平均分數 87 分，授課滿意度分別為 11/12 09:00-10:00：90%、11/13 14:30-15:30 ：88%、11/13 16:30-17:30：92%。
4. 完成增列之 2020 年 5CICU 能力進階計畫，並列入 N1~N4 學習歷程。

2019/12/5 評值學習效果不佳，再分析及對策：

1. N、N1、N2 在職教育後測分數平均皆未達 90 分以上：

2.1 授課內容與測驗範圍不一致，以致人員無法正確填答。

N 第四題內容，部分選項課程未提及。

N2 第五題內容，部分選項課程未提及。

2.2 因採行教材自學，未能即時進行討論，故有些疑問無法當場釐清。

改善：1.重新調整課程內容，與測驗題一致。2.晨間會議進行提問討論，釐清自學過程的疑問。

2. N3 課室滿意度未達 95%之分析：

1.1 因初次上課內容安排較多，原計 1 小時延遲至 1.5 小時。

1.2 該次授課目的未先溝通，導致人員較未能理解此計畫的目標。

1.3 授課內容含臨床案例的敘述，只能參加課室，時間無法配合者無法自學。

1.4 認證人力與單位三班人員排班困難，僅將能力提升至 N3 層級，尚未進行 N4 種子認證課程。
改善：於 N3 第一堂課結束後，即於單位宣導此計畫目的，並由單位主管於晨間會議宣導使單位同仁有共識，並與講師討論授課時間安排，於後續兩堂課室內容進行改善，規劃 N4 認證課程。

3. 補學機制：

改善：未參與 11/12-13 N3 課室教學者，由陳亭君、朱麗雯協助補教，100%完成該層級認證。

再對策後成效：

1.2019/11/30 晨間會議補充講述考題內提及之課室知能，2019/12/5~10 統整 N-N2 後測未達 90 分者，重新針對答錯題目者進行個別指導後，後測皆 100 分，達改善成效。

2.修改 N3 課程內容後，2019/12/20 針對 3 位未能參與 11/12-13 N3 課室教學的人員進行補學，通過率 100%，滿意度達 100%。

3.計畫於 2020/3/31 和 2020/4/1 完成單位 N4 種子認證，出席率、通過率、滿意度均為 100%。

最適策處置(A)

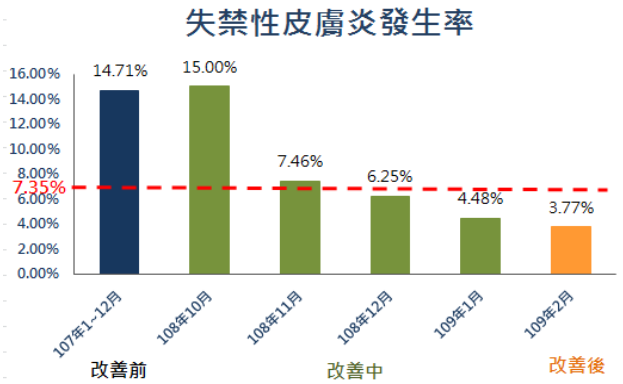
各層級 IAD 照護能力進階課程教學成效良好，故將各層級新修訂之 IAD 教案(含擬真教學)，納入單位能力進階計畫，並列出年度教育訓練計畫。2020/04/16 提案至加護病房科會，納入科共通教育訓練，以利平行推展。

玖、 效果確認

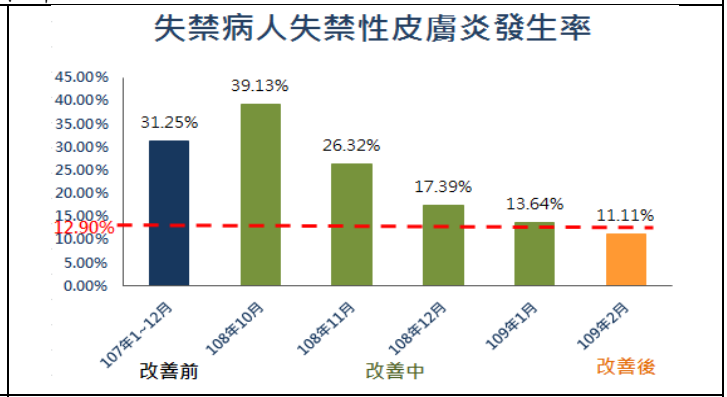
一、有形成果

(一)改善中與改善後數據蒐集，表十一：

who	負責收集數據之圈員：李姍珊護理師、朱麗雯護理師
where	收集數據地點：5C 加護病房
what	收集對象：5C 加護病房住院病人
why	收集數據之原因：追蹤失禁性皮膚炎發生率與失禁病人失禁性皮膚炎發生率下降情形。
how	收集數據之方法：每日以查核表進行臨床住院病人皮膚狀況稽查。
how many	收集數據期間所有之樣本數(分母)：追蹤 2019 年 10 月至 2020 年 2 月當月住院總人數、當月失禁性病人數為樣本數。
改善中數據 (2019.10.01~01.31)	**失禁性皮膚炎發生率**：2018 年失禁性皮膚炎發生率改善前為 14.71%，介入措施後改善中 2019 年 10 月發生率 15.0%，11 月發生率降至 7.46%，12 月發生率降至 6.25%，2020 年 1 月則降至 4.48%。 **失禁病人失禁性皮膚炎發生率**：2018 年失禁病人失禁性皮膚炎發生率改善前為 31.25%，經由措施介入後改善中 2019 年 10 月發生率 39.13%， 2019 年 11 月發生率降至 26.32%，12 月發生率降至 17.39%。2020 年 1 月則降至 13.64%。
改善後數據 (2020.02.01~02.29)	**失禁性皮膚炎發生率**：2020 年 2 月 3.77% 2018 年失禁性皮膚炎發生率 14.71%，2020 年 2 月的失禁病人失禁性皮膚炎發生率 11.11%，改善後下降 74.37%。 **失禁病人失禁性皮膚炎發生率**：2020 年 2 月 11.11% 2018 年失禁病人失禁性皮膚炎發生率 31.25%，2020 年 2 月的失禁病人失禁性皮膚炎發生率 11.11%，改善後下降 64.50%。



圖十七、改善後失禁性皮膚炎發生率長條圖



圖十八、改善後失禁病人失禁性皮膚炎發生率長條圖

製圖者：鐘麗芬/陳亭君 製圖日期：2020/03/01

(二)目標達成率

1. 失禁性皮膚炎發生率：

$$目標達成率\% = \left|\frac{改善後\ 3.77\% - 改善前\ 14.71\%}{目標值\ 7.35\% - 改善前\ 14.71\%}\right| \times 100\% = \mathbf{148.64\%}$$

$$進步率\% = \left|\frac{改善後\ 3.77\% - 改善前\ 14.71\%}{改善前\ 14.71\%}\right| \times 100\% = \mathbf{74.37\%}$$

2. 失禁病人失禁性皮膚炎發生率：

$$目標達成率\% = \left|\frac{改善後\ 11.11\% - 改善前\ 31.25\%}{目標值\ 12.90\% - 改善前\ 31.25\%}\right| \times 100\% = \mathbf{109.75\%}$$

$$進步率\% = \left|\frac{改善後\ 11.11\% - 改善前\ 31.25\%}{改善前\ 31.25\%}\right| \times 100\% = \mathbf{64.45\%}$$

二、延伸性(間接)效益

(一)IAD 病人接受排泄物清潔時的疼痛指數(CPOT 分數)平均值：由 8 分降低至 4 分。

(二)IAD 平均照護天數：由 9.12 天減少至 5.76 天。

(三)照護費用：每人每天平均減少 42+12.75+(32.13~53.55)+4,500=4,586.88～4,608.30 元。

1. 尿布：每人最少腹瀉 3 次/天×14 元/片=42 元/人日。
2. 清潔：潔膚液(200 元/236ml)=0.85 元/ml×每次約 5ml× 3 次/天=12.75 元/人日。
3. 防護:不同護膚品(300~500 元/28g)=10.71~17.85 元/g×至少使用 q8H/天=32.13~53.55 元/人日。
4. 三班護理師薪資：減少 4,500 元/人日。

(四)年效益=2020 年 IAD 27 人/7×12≒47 人/年×3.36 天/人×4586.88～4608.30 元≒724,360~727,743 元/人年。

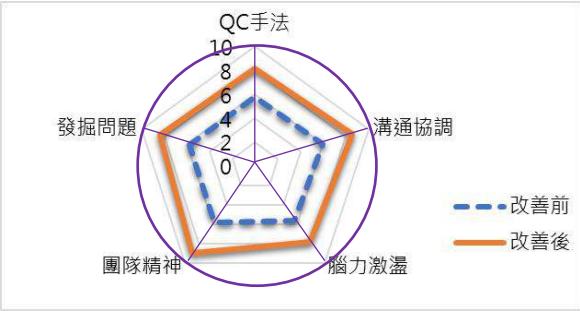
三、無形成果

(一)雷達圖評分表、雷達圖：如圖十九

以雷達圖十分量表調查品管圈運作前後之想法，發現圈員在「QC 手法運用」及「團隊精神」方面有明顯提升。

表十三、改善前後圈員能力雷達圖評分表

評分項目	評分標準					改善前		改善後		活動成長
	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	總分	平均	總分	平均	
QC 手法	不懂	知道	了解	運用	活用	53	5.8	82	8.2	+2.4
溝通協調	獨斷	詢問	諮商	協調	積極	54	6	86	8.6	+2.6
腦力激盪	普通	沉思	提出	延伸	潛能	51	5.6	78	7.8	+2.2
團隊精神	自我	猶豫	體會	互助	團結	53	5.8	90	9.0	+3.2
發掘問題	放任	注意	提出	思考	求解	53	5.8	84	8.4	+2.6



圖十九、改善前後圈員能力雷達圖

製表者/製圖者：李穎俐 製表日期：2020/04/01

註：1.全體圈員共 10 人(10/1 加入藥師一人)，分別就各評分項目之標準自我評價。
2.每項每人評分標準最高 10 分、最低 1 分。

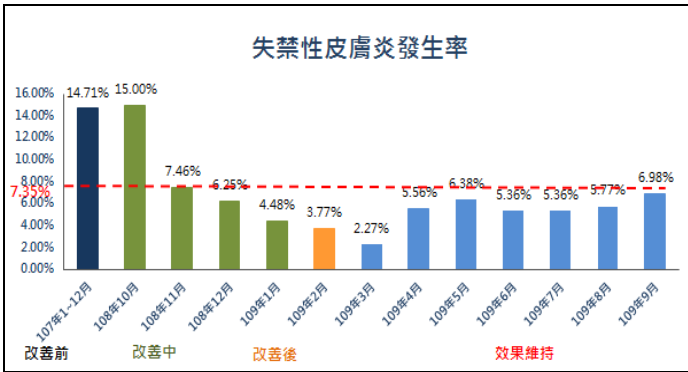
壹拾、 標準化

一、標準化作法與增修訂標準書內容

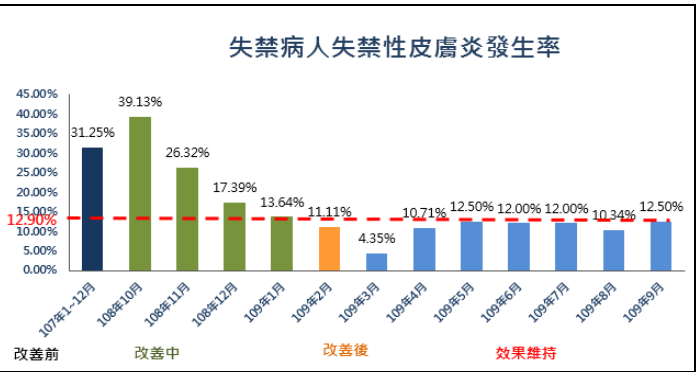
因改善成效良好，故新增以下標準書，並平行推廣至所有加護病房適用：

標準書編號	標準書名稱	最後修訂日期	初制訂日期
10-ICU-WIQI-001	品質指標收案標準書-加護組失禁性皮膚炎照護指標(附件十五)	2020/9/17	2020/4/13
10-7800-WI-112	重症單位病人排便處置及照護指導書(附件十三)	2020/8/12	2020/4/10
10-ICU-WIQD-012	成人紙尿布選擇與穿著術(附件七)	2020/9/17	2020/4/8

二、效果維持



圖二十、效果維持 IAD 發生率長條圖



圖二十一、效果維持失禁病人 IAD 發生率長條圖

製圖者：陳亭君/鐘麗芬 製圖日期：2020/10/5

三、體系內水平展開

對策成效良好，擬定「加護病房平行照護推展計畫」並持續推行，推展歷程如附件十六。

(一)皮膚通氣照護標準化：2020/4/16~6/31 將「成人紙尿布選擇與穿著術」及「紙尿布選擇醫病共享決策輔助工具」製作成線上影音教學推行至成人加護病房。並於 2020/9/17 加護科系科會通過將「成人紙尿布選擇與穿著術」及「加護單位品質指標-失禁性皮膚炎照護指標」變更為加護科系共通性指標，由加護科系科品管組進行管理。

(二)IAD 評估工具資訊化：2020/3/23~5/1 將「IAD 評估工具」推行至體系內三院區(永康、柳營、佳里)同步進行線上紀錄。

(三)增加攝入排出量跳出排便次數警示設定：2020/4/16~5/20 將「暫時性提示工具-水蜜桃掛牌」推行至成人加護病房，暫時取代「每日排便次數、克數超出腹瀉建議範圍資訊提示」。

(四)系統開立醫囑時出現腹瀉用藥決策支援：2020/4/16~2020/5/20 將「重症單位病人排便處置及照護指引」、「加護病房常用瀉劑 (Laxatives agent)及止瀉劑 (Antidiarrheal agent)指引」推行至成人加護病房，並於 2020/7/16 永康院區加護病房管理委員會會議通過將「重症單位病人排便處置及照護指引」改為「重症單位病人排便處置及照護指導書」，納入加護醫學部之標準書管理，適用於所有加護病房。

(五) IAD 教育訓練計畫納入學習歷程計畫：2020/4/16~6/30 完成各層級新修訂之 IAD 教案，列入加護單位各護理層級教育訓練認證課程。

四、院外水平展開：見附件十六。

(一) 2020/9/24 受邀至衛生福利部嘉義醫院舉辦**壓力性損傷與失禁性皮膚炎傷口照護與實作工作坊**。

(二) 2020/9/26 受 3M 明尼蘇達礦業及製造公司邀請至**提升照護品質-皮膚照護讀書會**授課。

(三) 2020/10/6 接受**南天有線電視台專題採訪**，並舉辦**公益記者會**，宣導民眾「**正確選擇與穿著紙尿褲，有效預防失禁性皮膚炎**」。

(四)預計 2020/10/26 接受警察廣播電台(節目部) Live 電話訪談，宣導民眾「**正確選擇與穿著紙尿褲，有效預防失禁性皮膚炎**」。

(五)預計 2020/11/20 由奇美醫療財團法人奇美醫院及中華民國急重症護理學會合辦**重症病人皮膚照護工作坊**。

壹拾壹、 檢討與改進

一、活動檢討

表十四、活動檢討一覽表

項目	活動步驟	優點	缺點	今後努力方向
1	主題選定	失禁性皮膚炎彙集文獻，形成 ABCDE 組合式照護模式	運用於單一內科加護病房，雖可平行推廣至內、外科加護單位，但一般住院病房病人照護模式與加護單位不同，故未能將一般病房住院臥床病人之失禁性皮膚炎列入改善。	了解各單位照護屬性，期能推廣至全院對於失禁性皮膚炎之照護。
2	活動計劃擬訂	計畫能在圈員互助中，協調如期完成進度。	成果評值和效果維持時期太短，應將時間拉長。	規劃未來活動成果評值能由兩個月延長至三個月，效果維持可達六個月。
3	課題明確化	圈員能夠依據院內作業流程，擬定出攻堅點	部分構思的攻堅點創意無限，但有院內成本考量或硬體設備及行政流程作業之限制。	在創意思考的構想，應同步思考組織內資源運用可行性，或與組織進一步溝通改善內容的可行性。
4	目標設定	具體可行、可測量	初期未掌握目標設定的技巧，目標設定過程太草率。	應掌握世界脈動，留意最新實證結果，以掌握單位、同儕及各國的現況水準，做為改善目標設定參考。
5	方策擬訂	圈員可以運用專業以及腦力激盪方法，提出適當方策，並依據方策擬定的措施，掌握進度內容。	部分方策需各委員會配合運作，故未能於效果確認時完成方策，而該部分亦未能納入評值項目故為缺失項目。	了解各提案部門的業務及作業流程，當方策擬定後，可先與負責部門討論，加速資訊化或新品試用流程及會議提案討論時程。
6	最適策追究	為確保每個方策都能順利進行，圈員開會討論方策方向，並多次進行表決內容。	過程偶爾可能因考量執行困難而萌生放棄部分方策的詳擬。	各圈員應有主動表達方策決議及提出建議之權益，避免落入多數人決議，少數人無意見的組內討論。
7	最適策實施與檢討	圈員能夠再多次會議過程，將各自負責適策內容分享，並提出困難點。	易淪於各自分工，無法掌握單位內執行後成果進度的追蹤。	依照工作內容進行權重分工，依據負責內容主動回報進度及追蹤評值的內容。
8	效果確認	能夠從中發現品質改善前中後的成效，強化圈員信心。	效果確認時間過短，無法突顯長期改善趨勢。	持續將品質活動拉長至一年半，持續觀察至少六個月的效果維持。
9	標準化	能運用跨領域方式完成「重症單位病人排便處置及照護指引」、「成人紙尿布選擇與穿著術」之擬訂。	標準化過程缺乏多位跨部門及領域專家代表參與，可能不夠詳盡。	標準化制定過程，應邀請跨部門及領域專家代表參與，協助審核作業標準之內容。
10	檢討與改進	圈員能針對整體運作，進行下次品質活動主題，累積經驗。	檢討過程易失焦，應針對問題點討論出明確解決方案。	會議進行中可導入新七大品管手法，讓每人充分表達意見。

製表人：陳亭君 製表日期：2020/04/30

二、餘留問題與後續計畫

表十五、活動殘留問題一覽表

殘留問題	目前改善情形
院內尿褲和成人替換式尿片試用	完成健〇成人紙尿褲、康〇馨、大〇替換式尿片試用，資材室比價中。
IAD 指標通報及後台管理機制	通過護理品質及護理作標委員會審核，資訊室排程中。

製表人：陳亭君 製表日期：2020/04/30

三、下期活動主題選定

(一)主題選定過程：表十六、主題一覽表

主題＼評價項目	可行性	迫切性	圈能力	重要性	得分	選定
降低外科加護病房給藥異常發生率	**46**	**48**	**44**	**50**	**188**	★
降低加護病房呼吸器導致肺炎感染率	42	44	44	38	168	
降低內科加護病房 MDRO 發生率	40	42	40	38	160	

評價說明	分/人	可行性	迫切性	圈能力	重要性
	1	次可行	次急迫	借助他人	次重要
	3	可行	急迫	部份需協助	重要
	5	極可行	極急迫	自行解決	極重要

(評分人數：10 人，分數為 10 人評分總和)

製表人：陳亭君 製表日期：2020/04/30

(二)活動主題：

1. 主題名稱：降低外科加護病房給藥異常發生率
2. 主題範圍：外科加護病房住院病人
3. 專有名詞：
   (1) **給藥異常**：給藥過程中，從處理醫囑至完成病人給藥過程中，所發生的藥物名稱、途徑、劑量、時間、病人等錯誤不良事件。
4. 本院依據醫療品質及病人安全年度工作目標，訂定住院病人給藥異常發生率公式為：

$$\frac{\text{當月給藥異常件數}}{\text{當月入住外科加護病房人日數}} \times 100\%$$

(三)選題理由：

1. 對病人而言：降低因給藥異常造成病人之傷害事件。
2. 對同仁而言：提升正確之給藥過程減少護理人員心理壓力。
3. 對院方而言：降低因給藥異常所產生醫療花費及住院天數。

壹拾貳、 參考文獻

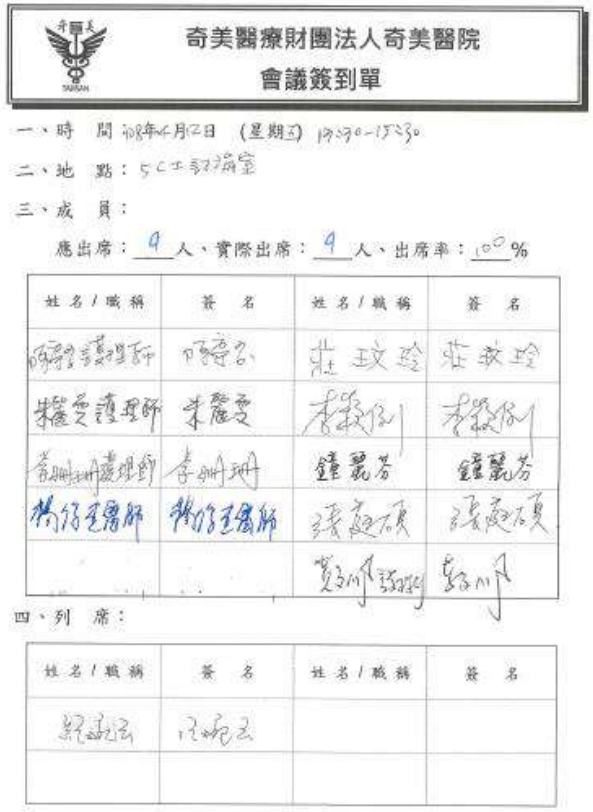
參考文獻彙整如附件十七。

附件

附件一：活動會議紀錄一覽表

表十五、會議記錄表

NO.	會議日期	進度內容	出席率	第一次會議紀錄及簽到單之掃描資料
1	108.4.12	圈的介紹、圈徽、單位簡介、確定文獻、主題選定、指標計算公式、選題理由、QC story 判定、雷達圖評分表、活動計畫擬定、課題明確化與收案流程	100%	
2	108.4.30	掌握項目	88.8%	
3	108.5.15	掌握項目	100%	
4	108.5.18	掌握項目擬定	88.85	
5	108.6.11	目標設定、方策擬訂	88.8%	
6	108.7.9	最適策追究-預測障礙排除檢討表	77.7%	
7	108.8.28	最適策實施與檢討(一)	55.5%	
8	108.9.12	最適策實施與檢討(二)	55.5%	
9	108.10.1	最適策實施與檢討(三)	7.%	
10	108.10.15	最適策實施與檢討(四)	70%	
11	108.11.21	最適策實施與檢討(五)	901%	
12	108.12.12	最適策實施與檢討(六)	90%	
13	109.1.15	效果確認(一)	100%	
14	109.2.15	效果確認(二)	90%	
15	109.4.22	效果維持(一)	90%	
16	109.9.12	效果維持(二)	70%	



奇美醫療財團法人奇美醫院

會議簽到單

一、時　間 108年4月12日 (星期五) 13:30-15:30

二、地　點：5C工研討室

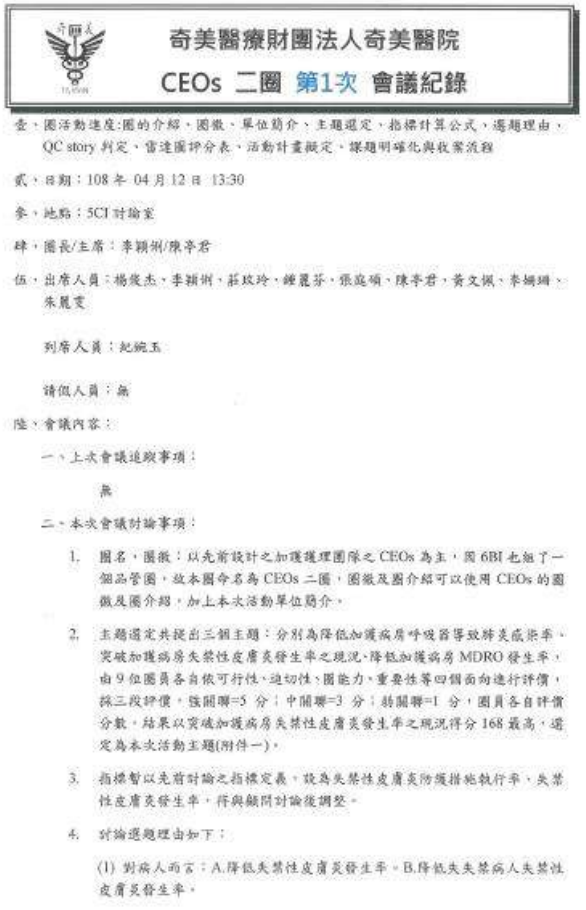
三、成　員：

應出席：9人、實際出席：9人、出席率：100%

姓名/職稱	簽名	姓名/職稱	簽名
護理師	[illegible]	莊玟玲	莊玟玲
護理師	朱麗雯	李穎俐	李穎俐
護理師	李姍珊	鍾麗芬	鍾麗芬
護理師	楊俊杰	張庭碩	張庭碩
		[illegible]	[illegible]

四、列　席：

姓名/職稱	簽名	姓名/職稱	簽名
[illegible]	[illegible]		



奇美醫療財團法人奇美醫院

CEOs 二圈 第1次 會議紀錄

壹、圈活動進度:圈的介紹、圈徽、單位簡介、主題選定、指標計算公式、選題理由、QC story 判定、雷達圖評分表、活動計畫擬定、課題明確化與收案流程

貳、日期：108 年 04 月 12 日 13:30

參、地點：5CI 討論室

肆、圈長/主席：李穎俐/陳亭君

伍、出席人員：楊俊杰、李穎俐、莊玟玲、鍾麗芬、張庭碩、陳亭君、黃文佩、李姍珊、朱麗雯

到席人員：紀婉玉

請假人員：無

陸、會議內容：

一、上次會議追蹤事項：

無

二、本次會議討論事項：

1. 圈名、圈徽：以先前設計之加護護理團隊之 CEOs 為主，因 6BI 也組了一個品管圈，故本圈命名為 CEOs 二圈，圈徽及圈介紹可以使用 CEOs 的圈徽及圈介紹，加上本次活動單位簡介。

2. 主題選定共提出三個主題：分別為降低加護病房呼吸器導致肺炎感染率、突破加護病房失禁性皮膚炎發生率之現況、降低加護病房 MDRO 發生率，由 9 位圈員各自依可行性、迫切性、圈能力、重要性等四個面向進行評價，採三段評價，強關聯=5 分；中關聯=3 分；弱關聯=1 分，圈員各自評價分數，結果以突破加護病房失禁性皮膚炎發生率之現況得分 168 最高，選定為本次活動主題(附件一)。

3. 指標暫以先前討論之指標定義，做為失禁性皮膚炎防護措施執行率、失禁性皮膚炎發生率，待與顧問討論後調整。

4. 討論選題理由如下：

(1) 對病人而言：A.降低失禁性皮膚炎發生率。B.降低失失禁病人失禁性皮膚炎發生率。

製表人：李穎俐　製表日期：2020/10/6

附件二、IAD 發生率之實證結果

NO.	標竿單位/作者	證據等級	改善主題/研究主題	改善要因	改善對策	改善成果/IAD 發生率	公式
1.	Wei et al., 2019	Level IV	IAD 危險因子預測	無	無	65.4%	IAD 人數/大小便失禁人數
2.	Wang et al., 2018	Level IV	IAD 危險因子	無	無	23.9%	IAD 人數/大小便失禁人數
3.	Coyer, Gardner, & Doubrovsky, 2017	Level III	皮膚照護於 IAD 的成效	降低發生率與嚴重度	結構式照護(bundle combining best available evidence)	實驗組 15 % 對照組 32%	IAD 人數/大小便失禁人數
4.	Gupta et al., 2017	Level IV	減少尿管的留置是否會導致 IAD 比率上升	降低 IAD 發生率	a. 頻繁檢視 b. 移除刺激物與髒污 c. 使用 Braden 危險評估工具 d. IAD 高風險病人執行組合式皮膚照護使用皮膚保護劑	18.84% 降至 8.33%	IAD 件數/分母未示
5.	Valls-Matarín et al., 2017	Level V	潮濕性皮膚炎發生率調查	無	無	26.20%	IAD 人數/大便失禁人數
6.	Zhou et al., 2017	Level III	大便失禁收集袋於 IAD 防護成效	降低發生率	實驗組:大便失禁收集袋 對照組:無	實驗組 12.9% 對照組 41.9%	IAD 人數/大小便失禁人數
7.	Chianca et al., 2016	Level IV	IAD 發生率與危險因子調查	無	無	20.4%	IAD人數/立意取樣
8.	三軍總醫院/莊、禹(2016)	Level VI	失禁性皮膚炎發生率	降為原發生率之 50%	a. 制定查檢表 b. 制定標準作業書 c. 規劃教育訓練 d. 更新表單設計 e. 建置清潔用水置放區	37.40%降至 16.6%	IAD 件數/分母未示
9.	健仁醫院/李、林(2015)	Level VI	失禁性皮膚炎發生率	依據單位 2012 年 1-6 月失禁性皮膚炎平均發生率 34.6%及參考徐等（2013）研究結果重症單位盛行率 26.32%	a. 訂定「高危險失禁性皮膚炎病人照護檢核表」 b. 高危險失禁性皮膚炎照護流程 c. 舉辦教育訓練	34.6%降至 21.5%	IAD 發生人數/ICU 住院總人數
10.	高醫大附設醫院/林等(2015)	Level VI	失禁性皮膚炎發生率	依據陳等（2008）改善因腹瀉導致失禁性皮膚炎發生率之專案設立目標應小於 22%	a. 設計高危險群標示、b.舉辦 6 場在職教育課程 b. 錄影教學課程 c. 製作失禁性皮膚炎預防及照護標準與流程圖 d. 製訂稽核制度	34.72%降至 19.8%	IAD 件數/人日數

附件三、尿布實測標準內容

CNS 標準值	項目	實測結果
無變形、破損、污漬	1.外觀	皆符合 CNS 標準無缺點
無	2.褪色現象	皆符合 CNS 標準無缺點
PH 值 4.0~8.7	3.酸鹼值	尿布表面材質均為弱酸性 PH6.0~6.5，貼近皮膚酸鹼值
縱向施尿量 500ml 以上，保留 400g 以上；橫向施尿量 100ml 以上，保留量 100g 以上	4.尿液保留量	健 X＝來 XX＝安 X(淨爽型)＝孝 X＞添 X＞大 XX＞院用＞康 XX(經濟型)
30g 以下	5.表面乾爽性(回滲量)	皆符合 CNS 標準小於 30g(介於 0.2~7.8g)
非 CNS 標準	6.透氣性	健 X＞來 XX＞添 X＞安 X＝安 XX＞安 X＞包 XX(全能防護)＞孝 X＞康 XX(經濟型)＞院用＝大 XX

附件四、紙尿布選擇醫病共享決策輔助工具

紙尿布選擇建議圖卡

	PE膜材質			不織布材質				
品項	安X	安X	包X	添X	安XX	來XX	健X	大X
回滲性	中量	中量	少量	少量	少量	中量	極少量	極少量
吸收力	中	中	中	中上	優	優	特優	特優
透氣性	差	差	差	中上	優	特優	特優	特優
防漏性	單層	單層	單層	單層	雙層	雙層	雙層	雙層
棉柔性	適中	適中	適中	優	優	優	特優	特優
腰圍彈性	無	擴展 6公分	無	擴展 14公分	無	擴展 9公分	擴展 9公分	擴展 10公分
重覆黏貼	✕	✕	✕	○	○	○	○	○
尺寸	L-XL 38-58吋	S-XL 23-62吋	S-XL 20-55吋	M-XL 28-57吋	S-XL 24-68吋	S-XL 22-56吋	M-L 32-55吋	M-L 23-49吋
產品特色	無	含鋅塗層 尿溼顯示	無	尿溼顯示	塗酸護膚 尿溼顯示	消臭(氨) 高分子	含奈米銀 集尿凹槽 尿溼顯示	消臭(氨) 高分子
價格	12-14元 /片	16-27元 /片	14-20元 /片	21-27元 /片	15-35元 /片	15-19元 /片	19-25元 /片	25-42元 /片
產地	台灣	台灣	台灣	台灣	德國	台灣/ 日本監製	台灣	日本

本內容為專案小組測試結果，內容僅供參考

附件五、修改院內尿布提案單

2017.06 修訂

一、 案由：更換院內成人紙尿褲廠商

二、說明：加護病房失禁性皮膚炎發生比率偏高，其中一項導因為目前使用院方提供的成人紙尿褲為 PE 材質，透氣效果差所致。

三、建議：為改善失禁性皮膚炎發生率，依據單位進行院內推動 QCC 進行失禁性皮膚炎發生率之改善案，比較各家成人紙尿褲廠商，以 CNS 標準測試，與院內現有成人紙尿褲比較需考量透氣性、保留性、回滲性，建議結果如下，將院內成人紙尿褲更換成其他廠牌不織布材質 S~XL 尺寸的成人紙尿褲，由護理行政委員會與廠商接洽議價並引用。

透氣性：健護>來復易>添寧=安家適>安安>包大人（全能）>院方

保留性：健護＝來復易=安安>添寧>院方

回滲性：全數符合 CNS 標準

四、附件：0 件	提案日期	108.12	提案單位	SCICU	提案者	陳亭君

五、協調說明：

說明如下：澄清：護理行政委員會是協助衛材試用提供結果給資材室參考由資材室評估考量後，議價簽約。護理行政委員會不會也不得與直接廠商議價。

1. 成人紙尿褲外層選材質有不織布及 PE 材質兩種，不織布材質較為透氣但 PE 材質防水性較佳及較不易回滲，適用於尿量較多患者。

2. 目前使用品牌-於去年經 ICU 試用合格才由資材議價採購，107 年 7 月簽約至 109 年 8 月，不得無故更換廠商。

3. 12/3 經與資材室協調：資材室會先找相關廠商進行試用，約滿後再議價採購。

	護理部部長		護理研發委員會	

協調後處理

同上。

六、受案單位回覆：（請於 月 日前回覆說明處理情形或處理計畫）

同上。

□已完成 □處理中：預計 完成 受案單位： 回覆日期：

附件六、建議修訂「加護病房自購衛材清單」提案單

奇美醫療財團法人奇美醫院
護理部提案單(檢會單)

T-108120

2017.06 修訂

一、 案由：成人加護病房個人衛生用品自購清單修改

二、 說明：修訂加護病房失禁性皮膚炎照護，目前已不建議小兒尿布用於成人尿、便失禁。

三、 建議：
1.小兒尿布(12-171-901)建議取消。
2.建議轉"臨床資源委員會"討論。

四、附件：0件	提案日期	108.12	提案單位	5CICU	提案者	陳亭君

五、協調說明：
建議轉臨床資源委員會。

	護理部部長		護理研發委員會	

協調後處理

六、受案單位回覆：(請於 月 日前回覆說明處理情形或處理計畫)
經評估成人已不使用小兒尿布進行照護，同意個人衛生用品自購清單移除小兒尿布品項。
☑已完成 ☐處理中：預計 完成 受案單位： 回覆日期：

七、提案單位回覆：☑結案 ☐需後續追蹤 ☐轉提案相關單位

提案單位：陳亭君 回覆日期：108.12.27

八、進度追蹤：

結案日：12/31

	護理部部長		護理研發委員會	

附件七、成人紙尿布選擇及穿著護理術

奇美醫療財團法人奇美醫院

文件類別	WI	文件編號	10-ICU-WI-QD-012
文件名稱	成人紙尿布選擇與穿著術		
制修單位	ICU	原始編號	10-3580-WI-QD-001

制修訂記錄

版次	日期	制修訂要點	制修訂者/單位	審查者/單位	核定者/單位
1.0	2020.04.08	初次制訂	張庭碩/獨麗芬	許瑜玲	李穎俐
2.	2020.09.17	於加護科科會決議通過將5CICU列管之成人紙尿布選擇與穿著術，改由護理部加護病房科品管組列管，於加護科組平行推展	李彩青	李彩青	

1.目的：

1.1 針對不同病人病況及排尿、排便型態，以及病家考量因素，提供病人及家屬合適的紙尿布選擇參考。

1.2 提供護理人員正確執行成人紙尿布穿著的方式。

1.3 預防因尿布穿著不當，造成病人膚潮濕浸渍的情形。

2.用物及設備：

2.1 皮尺

2.2 尿布：成人紙尿布(PE 膜、不織布材質)、成人替換式尿片(視需求)

2.3 看護墊(視需求)

2.4 乳膠手套

2.5 清潔用品:溫水、潔膚露、中性沐浴乳、濕紙巾、毛巾(視情況)

2.6 防護用品(視需求):長效隔離霜、氧化鋅保護膏、無痛性保護膜、造口粉

3.作業說明：

3.1 執行技術前：

步驟	要點說明
1. 洗手。 2. 至病人單位，拉隔簾。 3. 評估病人身高、體態並測量病人腰圍或臀圍。 4. 依據加護病房衛生用品管理辦法，準備尿布。	3.1 病人腰圍或臀圍測量方式： 腰圍：以肚臍為中心，繞過腰部，通過雙側骨盆腸骨上緣 。 臀圍：以恥骨聯合為中心，繞過雙髖部，或以 **(雙側髂骨距離*2)+2 公分**，測量距離如(左圖)。 4.1. 選擇院方代購衛材者，以院方代購之尿布為主；選擇家屬自購衛材者，由護理師針對不同病人病況及排尿、排便型態，及病家考量因素等，以「成人紙尿布選擇之醫病共享決策輔助工具」與病家共同討論並選擇適合病人的紙尿布(附件一)。 4.2. 以病人腰臀圍對照選定之廠商的尿布尺寸規格，選擇適合病人的成人紙尿布尺寸。 4.3. 紙尿布的選擇可區分兩類病人族群： 4.3.1 可下床活動及無失禁的病人：依病人活動頻率及男女性別不同，可選擇復健褲、褲型尿布，方便穿脫；若為短期臥床病人，則選用黏貼行紙尿布。 4.3.2 長期臥床及失禁的病人：依排尿及排便型態及量多寡(自解尿液、導尿管留置者)，可選擇吸成人替換式尿片。

3.2 執行技術中：

步驟	要點說明
1. 洗手 2. 攜用物至病人單位 3. 戴手套。 4. 去除衣褲，檢視有無排泄物，協助皮膚清潔。	4.1 依「床上沐浴技術」及「失禁皮膚護理術」協助皮膚清潔，提供照護。 4.2 若病人持續解便稀水狀，報告醫師評估增加封閉式引流系統(尿管、肛管…)。
5. 協助穿著成人紙尿布，依照：**捲→臀→拉→撫→貼→調**，六步驟順序穿著。 5.1 捲：捲好紙尿布備用 	5.1.1 將紙尿布攤開平整，使防漏側邊豎立，視病人排泄況狀，單用或將替換式尿片置於紙尿布的防漏側邊中央，捲好備用。 5.1.2 若病人排泄物常外漏，可視情況於紙尿布下方墊看護墊。
5.2 臀：對齊腰線、對齊尾骶骨中線 	5.2.1 紙尿布置於病人臀部，褲頭邊緣對齊腰圍、尿布中線對齊尾骶骨中線。
5.3 拉：拉平尿布與護墊	5.3.1 協助病人翻向另一側，將捲起的替換式尿布及紙尿褲拉出，維持平整。

5.4 撥：撥開防漏側邊

5.5 貼：尿布貼密合，貼好黏貼片

5.6 調：調防漏側邊，重新整理尿布

5.4.1 將巷換式尿片與紙尿布的防漏側邊向外撥展開，使防漏側邊貼合臀腿，並增加本體吸收面積，減少外漏情形。

5.5.1 將紙尿布貼合鼠蹊、會陰部，魔鬼氈成黏貼膠布左右對稱的貼在腹部黏貼，若穿著尿布不對稱，會增加外漏風險。

5.6.1 重新將紙尿布內的防漏側邊由鼠蹊部至臀部再次撥開，並調整紙尿布維持在病人感到舒適的位置。

3.3 執行技術後：

步驟	重點說明
1.脫手套，洗手 2.記錄排泄物顏色、量、性狀。 3.記錄臀部皮膚狀況與照護方式。	無。

4.參考文獻

蔡秀娟(2016)。*如何協助尿失禁患者選擇適當輔助用物*。取自 http://www.tcs.org.tw/community/assistance_index01_02.asp

Gray M, Kent D, Ermer-Seltun J, McNichol L. Assessment, Selection, Use, and Evaluation of Body-Worn Absorbent Products for Adults With Incontinence: A WOCN Society Consensus Conference. *Journal of Wound Ostomy Continence Nurs*. 2018;45(3):243-264

5.附件:

附件一、成人紙尿布選擇之醫病共享決策輔助工具

5.附件:

附件一、成人紙尿布選擇之醫病共享決策輔助工具

	PE膜材質			不織布材質				
品項	安X	安X	包X	添X	安XX	來XX	健X	大X
回滲性	中量	中量	少量	少量	少量	中量	幾少量	幾少量
吸收力	中	中	中	中上	優	優	特優	特優
透氣性	無	無	無	中上	優	特優	特優	特優
防漏性	雙層	雙層	雙層	雙層	雙層	雙層	雙層	雙層
棉柔性	被中	被中	被中	優	優	優	特優	特優
腰圍彈性	無	腰帶 6公分	無	腰帶 14公分	無	腰帶 9公分	腰帶 9公分	腰帶 10公分
重覆黏貼	✕	✕	✕	○	○	○	○	○
尺寸	L-XL 38-58吋	S-XL 23-62吋	S-XL 20-55吋	M-XL 28-57吋	S-XL 24-68吋	S-XL 22-56吋	M-L 32-55吋	M-L 23-49吋
產品特色	無	含鈦金屬 尿溼顯示	無	尿溼顯示	抗菌護膚 尿溼顯示	消臭(氨) 高分子	含奈米銀 無尿凹槽 尿溼顯示	消臭(氨) 高分子
價格	12-14元 /片	16-27元 /片	14-20元 /片	21-27元 /片	15-35元 /片	15-19元 /片	19-25元 /片	25-42元 /片
產地	台灣	台灣	台灣	台灣	德國	台灣/ 日本監製	台灣	日本

本內容為專案小組測試結果，內容僅供參考

附件八、中文版 IAD 嚴重度分級工具

臨床表現	IAD嚴重度	跡象**
	皮膚完整且無發紅（但有IAD的風險）	與其他身體部位相較之下，皮膚是正常的（沒有IAD的跡象）
	第一級－發紅*但皮膚完整（輕度）	發紅 +/-水腫
中度 重度	第二級－發紅*且皮膚破損（中至重度）	同第一級 +/-小水泡／大水泡／皮膚潰爛 +/-皮膚剝脫 +/-皮膚感染

* 對膚色較深的患者，局部受損皮膚顏色可能變淺、變深、紫色、深紅色或黃色。
**若患者沒有失禁，則不屬於IAD。

CMH-Dr
網際網路存取

附件九、IAD 嚴重度對應產品決策圖卡

附件十、中文版 IAD 嚴重分級工具及照護指南

附件十一、IAD 嚴重度分級工具及照護指南（APP）

附件十二、排便次數自動提示資訊化提案單

奇美醫療財團法人奇美醫院

護理部提案單(敬會單)

2017.06 修訂

一、 案由：護囑系統生命徵象大便次數與解便量的警示窗提示

二、說明：成人加護病房失禁性皮膚炎發生比率偏高，其中一項危險因子為每日解便3次以上或每日超過200克者，應即時介入防護措施，故資訊系統在生命徵象解便次數與解便量能設定鍵入上限提示，使護理人員早一步進行介入措施。

三、建議： 如附件，**鎖定成人加護病房與燒燙傷中心**生命徵象介面的排便次數由**當日時間切點 07:00-07:00**，鍵入次數大於兩次，或排便量建入總量超過200克/天者，即跳出一次警示窗「今日排便次數（量）超過上限，請進行失禁性皮膚炎防護措施。」，提醒護理人員進行失禁性皮膚炎防護措施。請護理資訊委員會協助修訂程式。

四、附件：一件	提案日期	108.12	提案單位	5CICU	提案者	陳亭君

五、協調說明：

	護理部部長		護理研發委員會	

協調後處理

六、受案單位回覆：（請於　月　日前回覆說明處理情形或處理計畫）

☐已完成　☐處理中：預計　　完成　受案單位：　　回覆日期：

七、提案單位回覆：☐結案　☐需後續追蹤　☐轉提案相關單位

提案單位：＿＿＿＿＿＿　回覆日期：＿＿＿＿＿＿

八、進度追蹤：

結案日：

	護理部部長		護理研發委員會	

附件十三、重症單位病人排便處置及照護指引

奇美醫療財團法人奇美醫院

文件類別	WI	文件編號	10-7800-WI-112
文件名稱	重症單位病人排便處置及照護指導書		
制修單位	加護醫學部	原始編號	10-3580-WI-QD-002

制修訂記錄					
版次	日期	制修訂要點	制修訂者/單位	審查者/單位	核定者/單位
1.0	2020.04.10	新編訂	邱婉君/鍾麗芬	5C 加護病房	李穎俐
2.0	2020.08.12	更改文件制修單位(由 5CI 加護病房改為加護醫學部及文件名稱(指引改為指導書)	黃麗美	李穎俐 109.8.12	加護病房管理委員會

奇美醫療財團法人奇美醫院

文件類別	WI			文件編號	10-7800-WI-112
文件名稱	重症單位病人排便處置及照護指導書				總頁次 4 頁 頁次：1
制修單位	加護醫學部	版次	2.0	最後編修日期：2020 年 08 月 12 日	

1 目的

1.1 提供臨床醫師與護理人員在加護病房之常用瀉劑及止瀉劑使用指引。

2 範圍：奇美醫院加護病房

3 權責單位：

3.1 文件制訂／修訂單位：加護醫學部。

3.2 文件審查單位／主管：加護醫學部/部長。

3.3 文件核定單位／主管：加護病房管理委員會 /主任委員。

3.4 文件發行單位：加護醫學部。

3.5 文件廢止單位：加護醫學部。

4 依據：

4.1 Drug information: Senna, Bisacodyl, Lactulose, Magnesium oxide, Loperamide, Racecadotril, Cholestyramine. Retrieved 2019 Nov 11th from www.uptodate.com.

4.2 藥物仿單：Sennapur, Dulcolax, Castor oil, Lactul, Magnesium oxide, Evac enema, Smecta, Imolex, Hidrasec, Choles Powder, Miyarisan-BM, LAC-B

5 名詞解釋：

5.1 便秘：由腸道開始提供營養開始連續 3 天未解便或一週排便次數少於 3 次。

5.2 腹瀉：每日解便量>3 次/天，或大便量>200 克(稀水、糊便)。

5.3 藥物－瀉劑 (Laxatives agent)

5.3.1 Sennapur/Sennoside A+B (12.5mg/tab)

5.3.2 Dulcolax/Bisacodyl (5mg/tab)

5.3.3 Castor oil/Oleum Ricini (30ml/BT)

5.3.4 Lactul/Lactulose (60ml/BT)

5.3.5 MgO/Magnesium oxide (250mg/tab)

5.3.6 Evac enema/Mono Na3PO4 (118ml/BT)

5.4 藥物－止瀉劑 (Antidiarrheal agent)

5.4.1 Smecta/Dioctahedral Smectite (3g/pack)

5.4.2 Imolex/Loperamide (2mg/cap)

5.4.3 Hidrasec/Racecadotril (10mg/pack)

5.4.4 Choles Powder/Cholestyramine (444.4mg/g)

5.4.5 Miyarisan-BM/Clostridium butyricum miyairi (40mg/g/pack)

5.4.6 LAC-B/Lactobacillus bifidus (1mg/1g)

6 執行地點：加護病房。

7 物品學儀：無。

8 作業內容：

8.1 藥物建議劑量與注意事項

8.1.1 瀉劑 (Laxatives agent)

藥物學名	藥物商品名	藥物規格	成人建議劑量	備註
刺激性/接觸性瀉劑 (Stimulant/Contact laxatives)				
Sennoside A+B	Sennapur	12.5mg/tab	1-2 tab HS	
Bisacodyl	Dulcolax	5mg/tab	1-2 tab HS	• 腸溶錠不可磨粉
Oleum Ricini	Castor oil	30ml/BT	• 口服每次 5-25 ml • 灌腸每次 15-60 ml	
滲透性瀉劑(Osmotically acting laxatives)				
Lactulose	Lactul	60ml/BT	便秘： 15-30 ml/day 肝腦病變： 30-45ml TID-QID	• 機轉為將水份拉往腸道中，需補充足夠水分。 • 限水病患可能影響藥效。 • 本品含少量葡萄糖及乳糖，糖尿病及半乳糖血症病人需謹慎使用(但非絕對禁忌)。
鹽類瀉劑(saline laxatives)				
Magnesium oxide	MgO	250mg/tab	1-2 tab TID-QID	• 長期使用易造成電解質不平衡，腎功能不全之病患應避免用含鎂之瀉劑。
Mono Na3PO4	Evac enema	118ml/BT	1 BT PRN	

8.1.2 止瀉劑 (Antidiarrheal agent)

藥物學名	藥物商品名	藥物規格	成人建議劑量	備註
Dioctahedral Smectite	Smecta	3g/pack	1 pack TID	• 應與其他藥物隔開 2~3 小時。
Loperamide	Imolex	2mg/cap	• 急性腹瀉：起始劑量 4mg，未效者可再加 2mg。 Max: 8mg/day • 慢性腹瀉： 4mg/day	• 此藥應避免用於細菌性腸炎、急性潰瘍性結腸炎與偽膜性結腸炎(CDI)，用藥前需確認無 CDI。
Racecadotril	Hidrasec	10mg/pack	Max: 60mg TID	• 健保規範：每療程使用不得超過 5 天。
Cholestyramine	Choles Powder	444.4mg/g	0.5-1 pack TID~QID， Max: 6 pack /day	• 應於服用本藥 1 小時前或 4~6 小時後再服用其他藥物。
Clostridium butyricum miyairi	Miyarisan-BM	40mg/g / pack	1 pack TID~QID	
Lactobacillus bifidus	LAC-B	1mg/1g	1~2 pack TID~QID	

8.2 藥物使用原則

8.2.1 用藥前評估病人便秘程度，如非頑固性便秘，刺激性/接觸性瀉劑建議從低劑量開始使用

8.2.2 瀉劑限制開藥天數，避免無症狀卻用藥而導致腹瀉。

(1) Sennapur：每次限開立7天。

(2) Dulcolax：每次限開立7天。

(3) Castor oil：限立即使用(STAT)。

(4) Lactul：每次限開立1天，用於肝腦病變者除外。

(5) MgO：每次限開立7天。

(6) Evac enema：限立即使用(STAT)。

奇美醫療財團法人奇美醫院

文件類別	WI			文件編號	10-7800-WI-112
文件名稱	重症單位病人排便處置及照護指導書				總頁次 4 頁 頁次：4
制修單位	加護醫學部	版次	2.0	最後編修日期：2020 年 08 月 12 日	

8.3 每日用藥最大劑量管控限制

8.3.1 當瀉劑醫囑處方開立時，電腦管控每日用藥最大劑量限制作為防呆機制

(1)每日最大量警告管控：當每日劑量大於此數量則跳出提醒視窗，但仍可開立使用。

(2)每日最大量鎖死管控：當每日劑量大於此數量則跳出提醒視窗並鎖死，無法開立使用。

藥物	每日最大量警告管控	每日最大量鎖死管控
Sennapur/Sennoside A+B	8 tab	16 tab
Dulcolax/Bisacodyl	6 tab	6 tab
Castor oil/Oleum Ricini	自費藥物無警告管控	3 BT
Lactul/Lactulose	18 BT	36 BT
MgO/Magnesium oxide	10 tab	20 tab
Mono Na3PO4/Evac enema	3 BT	6 BT

9 相關文件：無

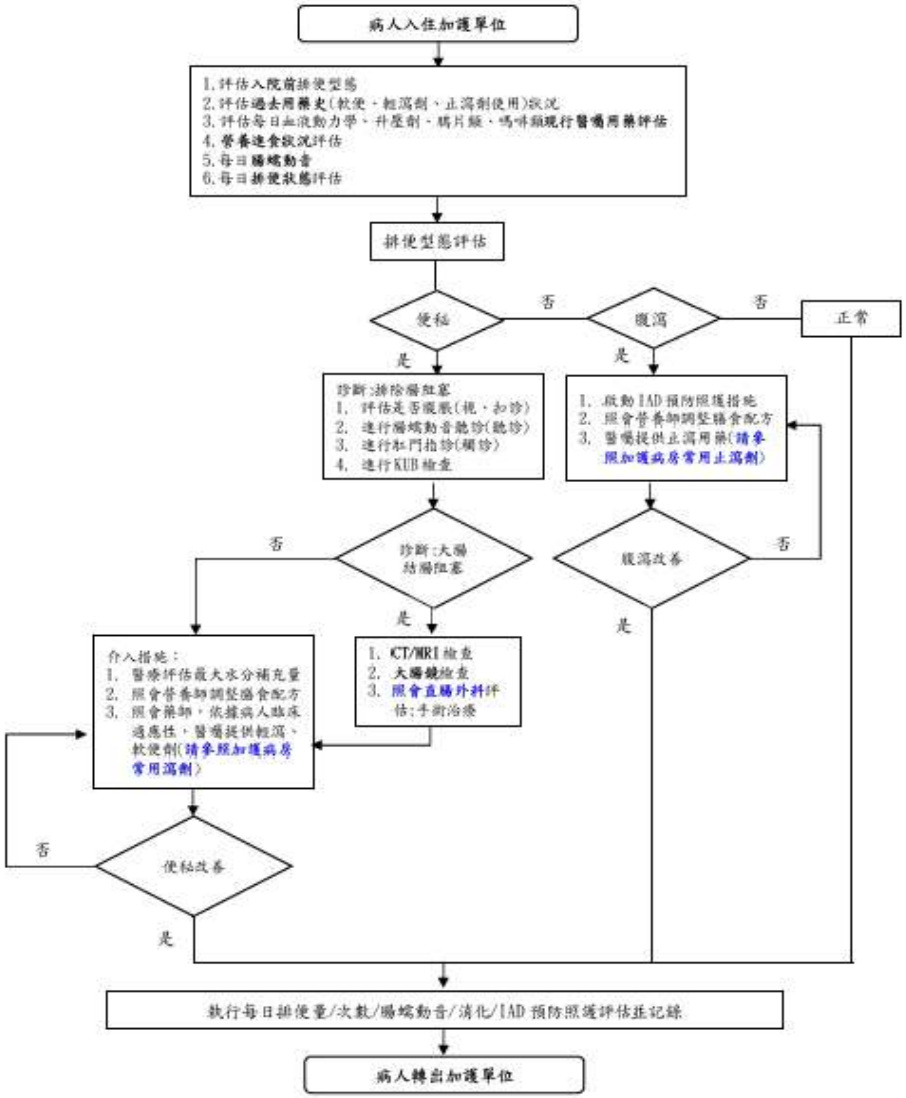
10 附件：

10.1 重症單位病人排便處置流程圖

10.2 5C 加護病房常用止瀉劑(Antidiarrheal agent)

10.3 5C 加護病房常用瀉劑(Laxatives agent)

附件 1： 重症單位病人排便處置流程圖



附件二 加護病房常用止瀉劑(Antidiarrheal agent)

加護病房常用止瀉劑 (Antidiarrheal agent)

奇美醫院藥劑部 製表 2019/11/11

健保價	藥物學名	藥物商品名	中文名	需與其他藥物隔開	藥物規格	成人建議劑量 (參考仿單及 Uptodate)	備註
5.6 元/pack	Dioctahedral Smectite	Smecta	舒腸達	V	3g/pack	1 pack TID 作用機轉：可吸附消化液及腸黏膜，但非腸一性故可與同時吸附腸道內藥物。	應與其他藥物隔開 2~3 小時。
2 元/cap	Loperamide	Imolex	依美洛		2mg/cap	• 急性腹瀉：起始劑量 4mg，未改善可再加 2mg，Max: 8mg/day • 慢性腹瀉：4mg/day 作用機轉：抑制腸道蠕動及分泌，且延長食糜通過時間與減少體積達到止瀉。	此藥應避免用於細菌性腸炎、急性潰瘍性結腸炎與偽膜性結腸炎(CDI)，用藥前需確認無 CDI。
7.8 元/pack	Racecadotril	Hidrasec	瀉必事		10mg/pack	Max: 60mg TID 作用機轉：水解後的活性代謝物，可抑制腦啡酸酶(enkephalinase)被分解，進而降低腸道因電動傳導或發炎而造成之水及電解質的過度分泌，但不會影響腸道基本的分泌活性。	健保規範：每療程使用不得超過 5 天。
15.4 元/pack	Cholestyramine	Choles Powder	可利舒散	V	444.4mg/g	0.5-1 pack TID~QID，Max: 6 pack /day 作用機轉：藥物中陽離子與膽汁不吸收離子結合形成不溶性複合物，因此降低膽汁酸的腸道再吸收。	應與服用本藥 1 小時前或 4~6 小時後再服用其他藥物。
優自費 95 元/pack	Clostridium butyricum miyairi	Miyarisan-BM	妙利散 BM		40mg/g /pack	1 pack TID~QID 作用機轉：益生菌-酪人菌(Clostridium butyricum MIYAIRI)，具有整腸效果。	
健保 2.59 元/pack，優惠期間健保給付後，自費 4 元/pack	Lactobacillus bifidus	LAC-B	洛克用顆粒		1mg/1g	1~2 pack TID~QID 作用機轉：益生菌-比菲德氏菌（Lactobacillus bifidus），具有整腸效果。	

附件三 加護病房常用瀉劑(Laxatives agent)

加護病房常用瀉劑 (Laxatives agent)

奇美醫院藥劑部 製表 2019/11/11

健保價	藥物學名	藥物商品名	藥物中文名	藥物規格	成人建議劑量 (參考仿單及 Uptodate)	開始作用時間 (onset)	備註
刺激性/接觸性瀉劑 (Stimulant/Contact laxatives)					作用機轉：增加腸道的蠕動，刺激腸道平滑肌的神經叢或刺激腸內水分及電解質的分泌。		
1.03 元/tab	Sennoside A+B	Sennapur	清立腹寧衣錠	12.5mg/tab	1-2 tab HS	6-24 hr	
2 元/tab	Bisacodyl	Dulcolax	樂可舒腸溶錠	5mg/tab	1-2 tab HS	6-12 hr	• 腸溶錠不可壓碎
優自費 126 元/BT	Oleum Ricini	Castor oil	蓖麻子油	30ml/BT	口服每次 5-25 ml 灌腸每次 15-60 ml	2-6 hr	
滲透性瀉劑(Osmotically acting laxatives)					作用機轉：在小腸中形成高滲透壓，將水引拉至腸腔中，並同時局部刺激腸壁，增加腸的蠕動，幫助排便。		
25.2 元/BT	Lactulose	Lactul	樂多糖漿	60ml/BT	便秘：15-30 ml/day 肝腦病變：30-45ml TID-QID	24-48 hr	• 作用機轉為將水引拉至腸腔中，無法吸收水分。 • 腎水病患可能影響排泄。 • **含少量葡萄糖及乳糖，糖尿病及半乳糖血症病人需謹慎使用(但非絕對禁忌)。**
鹽類瀉劑(saline laxatives)					作用機轉：增加腸道蠕動，刺激腸道水分及電解質增加，促進排便。		
0.16 元/tab	Magnesium oxide	MgO	氧化鎂錠	250mg/tab	1-2 tab TID-QID		• 長期使用易造成電解質不平衡，腎功能不全之病患應避免用含鎂之瀉劑。
35.8 元/BT	Mono Na3PO4	Evac enema	意復靈灌腸	118ml/BT	1 BT PRN		

※ **用藥決策：**

1. 限制開藥天數，避免無症狀服用藥物造成腹瀉→ Sennoside & MgO (7 天)，Bisacodyl (7 天)，**Lactulose** (2 天；**肝腦病變除外**)，Castor oil & Evac (Stat)
2. 用藥前評估病人便秘程度，如非頑固性便秘，刺激性/接觸性瀉劑建議從低強度開始使用

附件十四、教育訓練教案

奇美醫療財團法人奇美醫院

護理部教案「失禁性皮膚炎(Incontinence-associated dermatitis, IAD)照護」

製訂日期：108.10.08

表一 N0「IAD 照護」教案

教學對象	□到職訓練護理人員 ■新進人員(三個月) □第一年基層護理人員 □第二年基層護理人員 □N2 升 N3 □N3 升 N4	課程主題	失禁性皮膚炎照護之預防性照護
製作人	5CICU		
課程訓練目標	1. 具備照護一般病人之專業能力，勝任臨床照護工作。 2. 能遵循法規及專業倫理規範，以維護病人安全與權益。 3. 能瞭解跨領域團隊共同照護之概念，培養共同照護的模式。		
教學目標	1. 能判斷 IAD 高風險病人。 2. 能依評估結果提供防護措施。		
六大核心能力	■病患照護 □人際與醫病溝通技巧 ■醫學知識 □執業中學習與改進 ■專業素養 □系統為基礎之醫療		
學習評量	1. 課前:IAD 知能測驗卷。 2. 課後:IAD 知能測驗卷。		
教學內容	失禁性皮膚炎是臨床上常見的照護問題，而皮膚評估與照護是護理師基礎的專業能力。課前藉由自學，課中教師講述 IAD 定義、判斷 IAD 高風險病人、清潔皮膚方式、皮膚清潔劑的選擇及基礎 IAD 保護性產品使用，以提供適當的防護措施，建立學員於臨床照護失禁性皮膚炎病人之相關的基礎知識。 大綱： 1. 認識 IAD 定義，辨識高危險群及基本預防。 2. 瞭解清潔皮膚方式。 3. 認識皮膚清潔劑的選擇。 4. 瞭解基礎 IAD 保護性產品使用。		
教學設備	■電腦單槍投影機 □實物投影機 □投影機與投影片 □幻燈機與幻燈片 □海報看板 ■影片播放 □白板 ■試卷 □標準病人 □實物模型/模擬病人 ■教學評量表 ■其他：SWAY 或 PPT 檔案、失禁皮膚護理衛材		

教學活動

	教學內容	時間（分）	教學法及教材
課前	學員透過自學方式學習基礎 IAD 定義、判斷 IAD 高風險病人，提供防護措施。 學員完成 IAD 知能測驗卷。	30	➢ 自學法
課中	一、課前說明 1. 教學目標。 2. 教學內容。 3. 課程進行說明：講述教學與實作。	5	➢ 講述教學法
	二、講師講述過程，與學員互動，引導每位學員發言。 1. 由教師講述教學。 2. 學員提問其他問題，講師進行澄清補充及錯誤糾正。 3. 由教師帶領學員實作防護產品。	25	➢ 講述教學法 ➢ 問答法 ➢ 實際操作
課後	1.課後「IAD 知能測驗卷」筆試成績須達 80 分。 2.學員一週內完成線上滿意度評值。	10	➢ 試卷一份 ➢ 線上滿意度問卷

表二 N1「IAD 照護」教案

教學對象	□到職訓練護理人員 □新進人員 ■第一年基層護理人員 □第二年基層護理人員 □N2 升 N3 □N3 升 N4	課程主題	失禁性皮膚炎照護之 IAD 評估與處置
製作人	5CICU		
課程訓練目標	1. 具備照護一般病人之專業能力，勝任臨床照護工作。 2. 能遵循法規及專業倫理規範，以維護病人安全與權益。 3. 能瞭解跨領域團隊共同照護之概念，培養共同照護的模式。		
教學目標	1. 能正確應用 IAD 評估工具評估病人。 2. 能依評估結果提供個別性照護。		
六大核心能力	■病患照護 □人際與醫病溝通技巧 ■醫學知識 □執業中學習與改進 ■專業素養 □系統為基礎之醫療		
學習評量	1. 課前:IAD 知能測驗卷。 2. 課後:IAD 知能測驗卷。		
教學內容	失禁性皮膚炎是臨床上常見的照護問題，而皮膚評估與照護是護理師基礎的專業能力。課前藉由自學，課中教師講述 IAD 評估工具、IAD 嚴重等級之個別照護措施及應用 IAD 進階防護產品進行皮膚照護，建立學員於臨床照護失禁性皮膚炎病人之相關的基礎知識。 大綱： 1. 認識 IAD 評估工具。 2. 瞭解 IAD 嚴重等級之個別照護措施。		
教學設備	■電腦單槍投影機 □實物投影機		
	□投影機與投影片 □幻燈機與幻燈片 □海報看板 □影片播放 □白板 ■試卷 □標準病人 □實物模型/模擬病人 ■教學評量表 ■其他：SWAY 或 PPT 檔案、失禁皮膚護理衛材		

教學活動

	教學內容	時間（分）	教學法及教材
課前	1.學員透過自學方式學習基礎 IAD 評估與照護。 2.學員完成 IAD 知能測驗卷。	20	➢ 自學法
課中	一、課前說明 1.教學目標。 2.教學內容。 3.課程進行說明：講述教學與實作。	5	➢ 講述教學法
	二、講師講述過程，與學員互動，引導每位學員發言。 1.教師講述教學。 2.學員提問其他問題，講師進行澄清補充及錯誤糾正。 3.由教師帶領學員實作防護產品。	45	➢ 講述教學法 ➢ 問答法 ➢ 實際操作
課後	1.課後「IAD 知能測驗卷」筆試成績須達 80 分。 2.學員一週內完成線上滿意度評值。	10	➢ 試卷一份 ➢ 線上滿意度問卷

表三 N2「IAD 照護」教案

教學對象	□到職訓練護理人員 □新進人員 □第一年基層護理人員 ■第二年基層護理人員 □N2 升 N3 □N3 升 N4	課程主題	失禁性皮膚炎照護之 PI 與 IAD 判別
製作人	5CICU		
課程訓練目標	1. 具備照護一般病人之專業能力，勝任臨床照護工作。 2. 能遵循法規及專業倫理規範，以維護病人安全與權益。 3. 能瞭解跨領域團隊共同照護之概念，培養共同照護的模式。		
教學目標	1. 能辨識 PI 與 IAD 之差異。 2. 能依評估結果提供個別性照護。		
六大核心能力	■病患照護 □人際與醫病溝通技巧 ■醫學知識 □執業中學習與改進 ■專業素養 □系統為基礎之醫療		
學習評量	1. 課前:IAD 知能測驗卷。 2. 課後:IAD 知能測驗卷。		
教學內容	失禁性皮膚炎是臨床上常見的照護問題，而皮膚評估與照護是護理師基礎的專業能力。課前藉由自學，課中教師講述介紹 PI 與 IAD 之差異、PI 與 IAD 照護措施之差異，並以案例討論方式提升辨識能力，建立學員於臨床照護失禁性皮膚炎病人與壓力性損傷之判定，並提供正確		

	照護措施。 大綱： 1. 認識 PI 與 IAD 之差異。 2. 瞭解 PI 與 IAD 照護措施之差異。 3. 應用案例討論方式提升辨識能力。
教 學 設 備	■電腦單槍投影機 □實物投影機 □投影機與投影片 □幻燈機與幻燈片 □海報看板 □影片播放 □白板 ■試卷 □標準病人 □實物模型/模擬病人 ■教學評量表 ■其他：SWAY 或 PPT 檔案、失禁皮膚護理衛材

教學活動

教學內容		時間（分）	教學法及教材
課前	1. 學員透過自學方式學習基礎辨識 PI 與 IAD 能力。 2. 學員完成 IAD 知能測驗卷。	20	➢ 自學法
課中	1、 課前說明 1. 教學目標。 2. 教學內容。 3. 課程進行說明：講述教學與案例討論。	5	➢ 講述教學法
	二、講師講述過程，與學員互動、引導每位學員發言。 1. 教師講述教學。 2. 學員提問其他問題，講師進行澄清補充及錯誤糾正。 3. 由教師帶領學員以案例討論方式進行辨識 PI 與 IAD。	45	➢ 講述教學法 ➢ 問答法 ➢ 案例討論
課後	1.課後「IAD 知能測驗卷」筆試成績須達 80 分。 2.學員一週內完成線上滿意度評值。	10	➢ 試卷一份 ➢ 線上滿意度問卷

表四 N3「IAD 照護」教案

教學主題		**失禁性皮膚炎** (Incontinence-associated dermatitis, IAD)**困難照護**	教學對象：N2 升 N3
教學時間		課程總時間： 60 分鐘 (1) 教學 30 分鐘 (2) 實作 30 分鐘	上課人數： 人
教學情境	臨床情境	林先生，72 歲，酒精性肝硬化入住加護病房，因為氨指數上升，醫師醫囑 latulose 使用，服用後患者有水瀉情形，併發肛門會陰部片狀破皮與陰囊合併帶狀疱疹病毒感染。醫囑 Spersin oint BID PRN 使用，使用 1 日後，IAD 仍未改善。	
	受評者背景	護理人員已對腹瀉患者有肛門會陰部照護與預防失禁性皮膚炎的基本知能，但對於已嚴重破損且合併感染的患者卻不知如何照護。	
教學目標		N3 護理人員能達到： 1. 認知方面 (1) 認識IAD合併皮膚感染的類型 (2) 學習重度皮膚照護的處置 (3) 學習應用IAD進階防護產品進行皮膚照護 2. 情境方面 (1) 積極參與課程活動的討論並表達意見 3. 技能方面 (1) 能於課室中實際演練執行雙向回饋	

授課流程	**教學方法 (註記順序)**	**內 容**	**時 間**
	1. 討論法	1- 1 引起動機:IAD 照護的重要性	2 分鐘
		1- 2 教師與學習者討論臨床 IAD 照護困境	3 分鐘
	2. 講述法	2- 1 教師講述 IAD 合併皮膚感染的類型	5 分鐘
		2-2 教師講述 IAD 合併皮膚感染的照護	5 分鐘
	3. 示教	3-1 教師介紹重症 IAD 照護的用具與輔助衛材進行皮膚照護	5 分鐘
		3-2 教師示範重症 IAD 照護衛材的操作	10 分鐘
	4. 回覆示教	4-1 學員依教師提供的臨床實例相片，評估傷口，並能正確記錄。	8 分鐘
		4-2 學員依據評估結果，選擇合宜的衛材，回覆示教照護方式。	10 分鐘
	5. 小組討論	5-1 情境模擬結束，參與學員回饋操作者於回覆示教時，可以再調整與改進的空間。	7 分鐘
	6. 教師回饋	6-1 臨床教師依執行過程給予成效評量與教學回饋。	5 分鐘

教學資源	■電腦 ■單槍投影機 □實物投影機 ■模具 擬人屁股 □高階模擬人 □資料庫：_____ □IRS ■講師： 1 人 □教學評量工具：OOO 評量表 ■其他：臨床傷口實例相片、ＩＡＤ實物衛材	
	教學評量工具說明： 1.基本資料：失禁性皮膚炎題庫 2.評量重點：提升失禁性皮膚炎合併感染的評估與照護能力 3.評分標準：完成前後測考題、完成 IAD 照護查核表 4.及格標準： (1) 課後測試結果 80 分 (2) IAD 照護查核表：除 NA 項目外，所有題項均須達 4 分(含)以上，各題項中之必要條件均須至少達到標準。 5.雙向回饋：於每次教學演練結束後進行，以口頭進行教學過程優缺點之討論與回饋，瞭解學員之學習成效。	
評值	評值內容	評值方法
	1. 失禁性皮膚炎合併感染的照護知能	1.前測與後測：是非題與選擇題
	2. 能正確評估失禁性皮膚炎合併感染	2.前測與後測：是非題與選擇題
	3.正確選用與使用照護 IAD 之衛材	3. IAD 照護查核表： □1-2 分未達標準；□3 分接近標準；□4 分達到標準； □5-6 分超過標準；若無此項可觀察，則填 NA。
教學重點及注意事項	1.能掌握教學時間。 2.引導學員參與討論。	

N4「IAD 照護」教案

教學主題		**失禁性皮膚炎** (Incontinence-associated dermatitis, IAD)**種子教師認證**	教學對象：N4
教學時間		課程總時間： 90 分鐘，10 分鐘/每人 (1) 口頭報告 8 分鐘/每人 (2) 回饋討論 2 分鐘/每人	上課人數： 9 人
教學情境	臨床情境	以一對一方式進行 N4 認證，由教師準備考題，分成兩部分進行評量: IAD 級數評估和一個困難性 IAD 照護情境的案例。依學員人數規劃，每位學員有 10 分鐘時間進行評量。 例如：重症內科加護病房，患者黃女士，65 歲，胰臟炎併呼吸道衰竭，有糖尿病病史，全身水腫，幾次管灌後，開始有腹瀉的情形，每班解 3 次稀糊便，雖然主護護士已經執行基本的皮膚清潔與使用 ZNO 保護肛門會陰部皮膚，但是肛門會陰部皮膚從發紅，變成點狀破皮，且發紅蔓延至尾椎。主護不確定目前的照護方式是否適合？或者需改變照護方式？乃至不確定是否該通報壓力性損傷？或者 IAD 的最重級數為何？	
	受評者背景	N4 護理人員並具備N0-N3 的IAD照護能力，準備成為IAD種子教師。	
教學目標		受評學員能達到： 1. 認知方面 (1)了解IAD照護N4 認證教案設計。 (2)能獨立判斷IAD評估及照護並提供臨床具體建議。 2. 情境方面 (1)積極參與課程活動的討論並表達意見 (2)願意運用IAD評估工具於臨床教學與臨床照護實務 3. 技能方面 (1) 認證完成後，能熟練執行IAD臨床病人照護。 (2) 運用成熟IAD評估與照護能力，輔導臨床人員正確執行IAD臨床病人照護。	
授課流程		**教學方法 (註記順序)**	**內 容**	**時 間**
		1. 講述法	1-1 教師開場，說明 IAD 評量的內容、步驟、各評量項目的定義及評量標準。	0.5 分鐘
		2. 圖示考題測試	2-1 每位學員依照圖示進行 IAD 級數評估測試。	8 分鐘/每位
		3. 技術操作測試	3-1 執行困難性 IAD 照護的案例分析。 3-2 能正確說出案例的 IAD 級數評估 3-3 能正確執行案例的 IAD 照護技術	
		4.相互回饋	4-1 教師依學員口頭報告結果，給予成效評量與教學回饋。	1.5 分鐘/每位

教學資源	■電腦 ■單槍投影機 □實物投影機 ■模具 □高階模擬人 □資料庫：_____ □IRS ■講師： 1 人 ■教學評量工具：試卷、技術測試評量表 □其他：	
	教學評量工具說明： 1.基本資料： 學員姓名： 單位： 職級： 年資： 員工號： 評量日期： 評量地點： 2.評量重點：能獨立判斷 IAD 照護並提供臨床具體建議 3.評分標準：分為兩部分， 第一部份為 IAD 級數評估測試；第二部份為困難性個案評估與實際操作。 4.及格標準：IAD 級數評估測試與困難性個案評估及實際操作，成績須各達 80 分以上。 5.雙向回饋：於報告結束後進行，以口頭進行案例過程優缺點之討論與回饋，瞭解學員之學習心得與成效。	
評值	評值內容	評值方法
	1. 完成 IAD 級數評估	達 80 分以上
	2. 完成困難性 IAD 個案照護分析	達 80 分以上
	3. 課程評值	課程評值滿意度
教學重點及注意事項	1.教師能掌握教學時間。 2.教師引導學員參與討論。 3.當年度完成 N4 種子教師資格者，隔年（每年）需擔任單位 N1 與 N2 之授課師資，至少各 1 次，以維持種子教師資格。種子教師授課內容，由傷口護理師輔導。	種子教師資格維持： 1. 每年擔任 IAD 之 N1 師資，1 次。 2. 每年擔任 IAD 之 N2 師資，1 次。

學員姓名:
人事號:
日期:
成績:
一、IAD 評估圖示測試評量

題號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	總分
答案											

二、IAD 技術操作測試評量

	項目	項目內容	配分	評分
1	評估	能判斷目前因疾病所導致的主要護理問題	10	
		能正確評估案例的 IAD 分級	10	
		能說明該案例 IAD 照護的學理依據	10	
2	用物準備	用物的選擇適當(含清潔、保護、修復)如下:		
		清潔:清水或皮膚清潔產品	10	
		保護:保護隔離霜或護膚膏或無痛性保護膜	10	
		修復:適透膜粉(造口粉)或高效皮膚保護劑	10	
3	操作技能	能正確執行 IAD 護理步驟如下:		
		執行過程動作輕柔、熟練、流暢	10	
		清潔方向由前往後	10	
		清潔以按壓方式	10	
		能依照案例狀況選擇適當的用物	10	
	總分		100	

附件十五、品質指標收案標準書—加護組失禁性皮膚炎照護指標

奇美醫療財團法人奇美醫院

文件類別	WI	文件編號	10-ICU-WI-QI-001
文件名稱	品質指標收案標準書—加護組失禁性皮膚炎照護指標		
制修單位	ICU	原始編號	10-3580-WI-QI-003

制修訂記錄

版次	日期	制修訂要點	制修訂者/單位	審查者/單位	核定者/單位
1.0	2020.04.13	初次制訂	陳平君	許瑜玲	李穎倒
2.0	2020.09.17	「加護科品管決議通過將5CICU列管之品質指標收案標準書-失禁性皮膚炎照護指標，改「加護病房改為加護科品管組指引書」，以於加護科組平行推展	李紘青	李紘青	[illegible]

奇美醫療財團法人奇美醫院

文件類別	WI			文件編號	10-ICU-WI-QI-001
文件名稱	品質指標收案標準—加護組失禁性皮膚炎照護				總頁次 4 頁 頁次：1
制修單位	ICU-科品管	版次	2.0	最後編修日期：2020 年 09 月 17 日	

1 目的：

皮膚是人體抵抗細菌、微生物入侵及物理與化學性創傷之保護屏障。一旦皮膚受損，則易造成疼痛、毀形及固定不動，影響生活品質甚劇，若傷口不癒合，易引發感染、敗血症，導致住院天數延長，增加照護成本支出 (Ratiliff & Fletcher, 2007)。2007 年學者首度提出潮濕為導致皮膚防護降低的因子之一，稱為 Moisture-associated skin damage(MASD)(Gray, Bohacek, Weir, & Zdanuk, 2007)。 2011 年 Gray 等人定義潮濕來源可分為四大類，其中一類是失禁性皮膚炎 Incontinence associated dermatitis; IAD(Gray et al., 2011) 。

加護病房因疾病嚴重度高、用藥多，藥物副作用常使病人伴隨腹瀉情形，因病情臥床限制、或制動，大小便失禁使用尿布看護墊，若未即時處理或護理方法不當，易使皮膚暴露於潮濕環境下，造成失禁性皮膚炎發生，進而加重病人病情及延長住院天數。因此，預防失禁性皮膚炎是加護病房護理照護之重要任務，也可反應一個加護病房的護理照護品質。因此，本單位制定失禁性皮膚炎照護流程及品管指標監測計劃，以確保護理人員對失禁性皮膚炎的照顧品質，並經由單位品管指標組每月的統計相關指標以進行單位照護品質之評值改善。

2 範圍：為所有 ICU 住院病人臨床層面照護範圍。

3 權責單位：

3.1 文件制訂／修訂單位：護理部加護科品管組員/護理部加護科組科品管組員。
3.2 文件審查單位／主管：護理部加護科品管負責人/護理部加護病房科督導。
3.3 文件核定單位／主管：護理部加護科品管負責人/護理部加護病房科督導。
3.4 文件發行單位：護理部加護科品管組。
3.5 文件廢止單位：護理部加護科品管組。

4 依據

Beeckman, D., Campbell, J., Campbell, K., Chiment o, D., Coyer, F., Coyer,F. & Wang, L. (2015).Proceedings of the global IAD expert panel: Incontinence-associated dermatitis: Moving prevention forward. Retrieved from http://www.woundsinternational.com.

Black, J. M., Gray, M., Bliss, D. Z., Kennedy-Evans, K. L., Logan, S., Baharestani, M. M., ... & Ratliff, C. R. (2011). MASD Part 2: Incontinence-Associated Dermatitis and Intertriginous Dermatitis A Consensus. Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing, 38(4),359-370.

Clemens, J. Q. (2019, August 5). Urinary incontinence in men. Retrieved from https://www.uptodate.com.

Gray M. (2007). Incontinence related skin damage: essential knowledge. Ostomy/Wound Manage, 53(12):28-32.

Gray M, Black JM, Baharestani MM, Bliss DZ, Colwell JC, Goldberg M, Kennedy-Evans

1

KI., Logan S, Ratliff CR,. (2011) Moisture-associated sin damage: overview and pathophysiology. J Wound Ostomy Continence Nurs, 38(3), 233-41.doi:10.1097/WON.0b013e318215f798.

Gray, M., Beeckman, D., Bliss, D. Z., Fader, M., Logan, S., Junkin, J., ... & Kurz, P. (2012). Incontinence-associated dermatitis: a comprehensive review and update. Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing, 39(1), 61-74.

Ratliff, C., & Fletcher, K. (2007). Skin tears: A review of the evidence to support prevention and treatment. Ostomy/Wound Management, 53, 32-34.

Robson, K. M., & Lembo, A. J. (2018, August 5). Fecal incontinence in adults: Etiology and evaluation. Retrieved from https://www.uptodate.com.

5 名詞解釋：

5.1 失禁性皮膚炎(incontinence-associated dermatitis, IAD)：失禁性皮膚炎(Incontinence-associated dermatitis, IAD)：失禁性皮膚炎指暴露於尿液或糞便所造成的皮膚損傷反應(Black et al., 2011)。臨床症狀為紅斑、紅疹、浸潤、糜爛，甚至皮膚破損，可能伴隨著感染的發生 (Gray et al., 2012)。2015 年由全球 IAD 專家小組頒布(Beeckman et al.,2015)依嚴重程度分級。

5.1.1 第 0 級：皮膚完整且無發紅(但有 IAD 的風險)

5.1.2 第 1 級(輕度)：發紅但皮膚完整

5.1.3 第 2 級(中度)：發紅且皮膚有點狀破皮

5.1.4 第 2 級(重度)：發紅且皮膚有片狀破皮

5.2 失禁病人：包含所有大便失禁或小便失禁症狀的病人。大便失禁是指不自主的排出固體及液體的糞便(Robson, 2018)。而小便失禁是指任何不受控制的尿液洩漏(Clemens, 2019)。如病人穿著尿布，只要無尿管，則視為尿失禁；如有一天解超過 3 次不成型便，或液狀糞便大便量每日大於 200 克便以及有解血便情形，則視為便失禁。

6 執行地點：為所有 ICU 住院病人臨床層面照護範圍。

7 物品準備：無

8 作業內容：

8.1 指標性質：與結果有關。

8.2 指標種類：落後指標。

8.3 確認重要的照護面：

8.3.1 重要的照護面：皮膚照護。

8.3.2 選擇原則：高風險、高等量、高成本、具問題傾向之照護活動。

8.3.3 照護面之重要性與監測頻率：屬於極重要的照護面，故採每月一次。

8.4 確認指標：

8.4.1 指標名稱與項目：

(1) 指標名稱：皮膚照護

(2) 指標項目：

A 失禁性皮膚炎發生率

B 失禁病人失禁性皮膚炎發生率

8.5 收集資料與整理資料：

此品管指標計劃依循護理部作業標準委員會訂定之「失禁皮膚護理術」執行皮膚護理。病人入院當班，須進行初次評估，識別高風險性失禁性皮膚炎病人，並依皮膚狀況進行皮膚防護照護措施。如為失禁病人，或存在第 1、2 級失禁性皮膚炎的病人，由當班主護線上通報「失禁皮膚炎」(附件 2)。然各指標之分子納入條件，僅限當月「入院後」才發生之失禁性皮膚炎事件。

8.6 建立評值閾值與指標整理:

初期閾值設定以文獻為參考值，其閾值設定失禁性皮膚炎發生率 7.35%，失禁病人失禁性皮膚炎發生率 12.9%，先以推移圖呈現，待指標穩定後，採行 P chart CL±3 標準差之管制範圍。

8.7 收集資料與整理：

8.7.1 收集資料：此品管指標計劃依循護理部作業標準委員會訂定之「失禁皮膚護理術」執行皮膚護理。病人入院當班，須進行初次評估，識別高風險性失禁性皮膚炎病人，並依皮膚狀況進行皮膚防護照護措施。如為失禁病人，或存在第 1、2 級失禁性皮膚炎的病人，由當班主護線上通報「失禁皮膚炎」(附件 2)。然各指標之分子納入條件，僅限當月「入院後」才發生之失禁性皮膚炎事件；品管指標負責人每月 6 日前統計上月發生件數，計算失禁性皮膚炎發生率以及失禁病人失禁性皮膚炎發生率，進行資料統計報表製作，指標計算公式如下：

(1)指標要素

A.失禁性皮膚炎發生率

$$\frac{\text{分子：當月失禁性皮膚炎發生人數}}{\text{分母：當月住院病人總人數}} \times 100$$

B.第 0 級失禁性皮膚炎發生分率

$$\frac{\text{分子：當月第 0 級失禁性皮膚炎發生人數}}{\text{分母：當月失禁性皮膚炎發生人數}} \times 100$$

C.第 1 級失禁性皮膚炎發生分率

$$\frac{\text{分子：當月第 1 級失禁性皮膚炎發生人數}}{\text{分母：當月失禁性皮膚炎發生人數}} \times 100$$

D.第 2 級(中度)失禁性皮膚炎發生分率

$$\frac{\text{分子：當月第 2 級(中度)失禁性皮膚炎發生人數}}{\text{分母：當月失禁性皮膚炎發生人數}} \times 100$$

E.第 2 級(重度)失禁性皮膚炎發生分率

$$\frac{\text{分子：當月第 2 級(重度)失禁性皮膚炎發生人數}}{\text{分母：當月失禁性皮膚炎發生人數}} \times 100$$

8.8 整理指標:

指標項目	參考標準	資料來源	收集方式	資料分析	閾值
失禁性皮膚炎發生率	文獻查證	失禁皮膚炎照護分析單	每月由統計表了解其比率	先以推移圖呈現	7.35%
失禁病人失禁性皮膚炎發生率	文獻查證	失禁皮膚炎照護分析單	每月由統計表了解其比率	先以推移圖呈現	12.9%

8.9 評值照護：

每月品管指標負責人依據資料收集結果由品管指標負責人登錄建檔，每月3日前應用推移圖進行判讀分析，並提出改善。

8.10採取行動以改善照護：

品管指標負責人依據皮膚照護結果進行分析，當確立問題之導因後經由單位品管指標組會議討論後，提出改善方案，再由品管指標負責人隨時修正行動。

8.11評估行動效果及確保成果：

品管指標負責人評值改善措施之有效性並記錄，依據報表結果進行資料分析，並依數據閾值趨勢進行檢討改善。

8.12傳達相關訊息：

品管指標負責人建置指標報表，並呈報改善措施推行困難及成效於護理品管組組長→護理長→科督導核閱。

9.相關文件：無

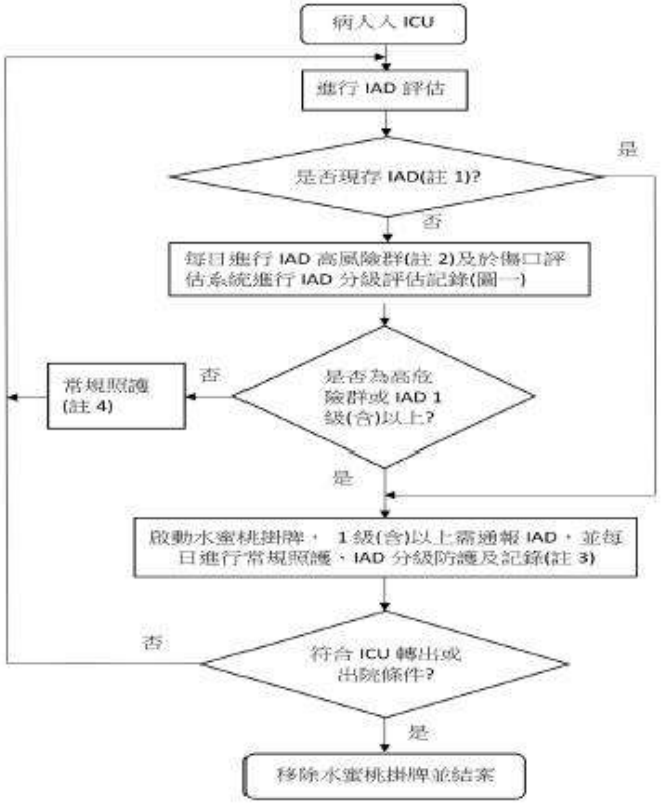
10.附件：

附件一：失禁性皮膚炎照護流程

附件二：失禁性皮膚炎照護記錄單(google 表單範本)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdabOL1MU7FIZrlq6uFV_JfoemPtkfvZN8sz16wU9eukmi07A/viewform

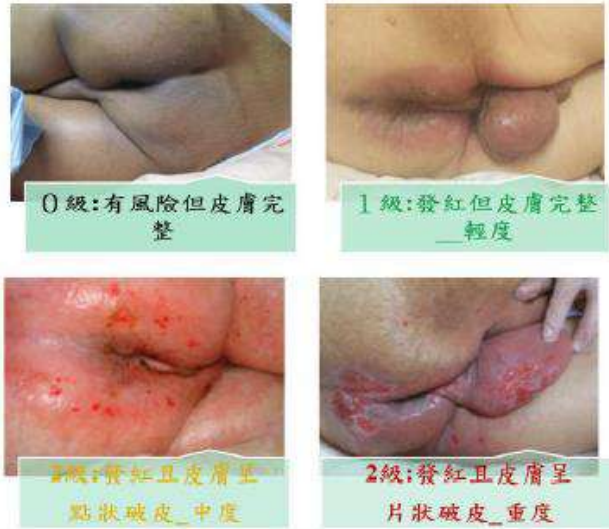
附件一、失禁性皮膚炎照護流程



註 1. 現存 IAD 定義為 IAD 分級 IAD 1 級(含)以上者。
註 2.IAD 高危險群為每日 07:00~07:00 解便量 3 次、解便量達 200 克者。
註 3.請依 IAD 級數下立護理問題，並依 IAD 評估照護指南圖表(圖二)、IAD 結構式組合照護產品（圖三）執行 IAD 分級防護照護。
註 4.常規照護：請遵從成人紙尿布選擇與穿著術，及重症單位病人排便處置及照護指引執行臨床照護，若已依指引使用緩瀉劑仍滲便者，可依醫囑給予肛門軟塞使用，但須每 12 小時更換，避免黏膜壓傷。

6

圖一、IAD 分級圖示



圖二、IAD 評估照護指南圖表

7

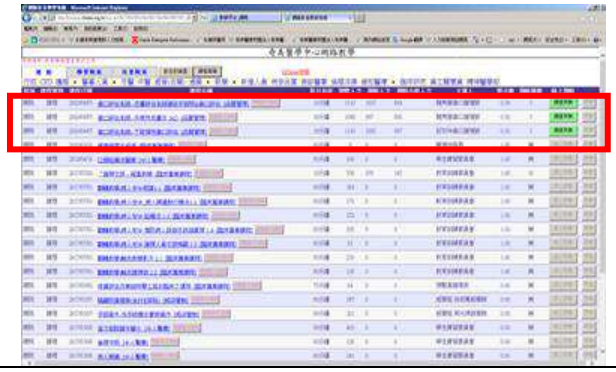
圖三、IAD 結構式組合照護產品

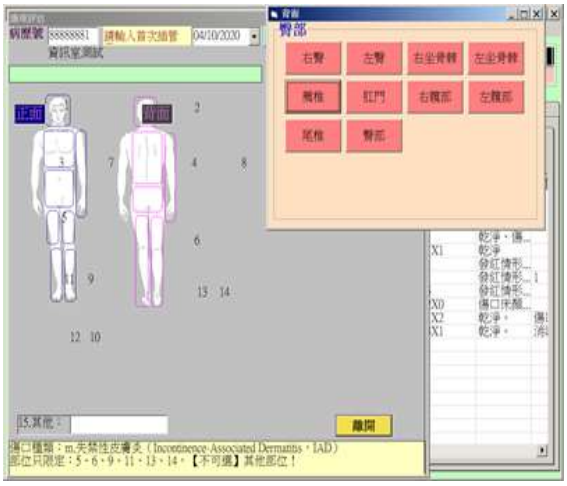
預防 0 級者適用：保護霜	失禁性皮膚炎 1、2 級者適用：保護膏(含氧化鋅)			
3M™ Cavilon™ 長效保護霜 容量: 28g NT:300 容量: 92g NT:580	慕之格斯 VBC 全效護膚膏 容量: 50 ml NT:240-320 容量:100 ml NT:370-520	Baan 貝恩嬰兒全效護膚膏 容量: 50ml NT:240	貝布 Bebble 親膚花花膏 容量: 75ml NT:270-300	"唐成"蓋爾護膚軟膏 容量: 56g NT:370
失禁性皮膚炎 1、2 級者適用：無痛性保護膜				
3M Cavilon™無痛性保護膜 容量: 28 ml NT:550	史密斯 smith&nephew 容量: 28 ml NT:450-500	達膚舒 無痛保護膜 容量: 50 ml NT:450	泰坦 Taicend 液態保護膜 容量: 70ml NT:450-500	Silesse™"唐成"無痛保護膜 容量: 50ml NT:558-620
失禁性皮膚炎 2 級以上敏感體質者適用		相關護理用品		
3M™ Cavilon™ 高效保護劑 每周使用 2-3 支/次 NT:600/支	唐成 通透撒粉 StomahesivePowder 容量: 25.3g NT:248- 320	唐成 蓋爾清潔洗液 容量: 118ml NT:200 元 236ml NT:320 元	3M™ Cavilon™ 乾洗潤膚液 容量:236ml NT:150-200	乾濕兩用護理巾 (20 片) NT:25-35

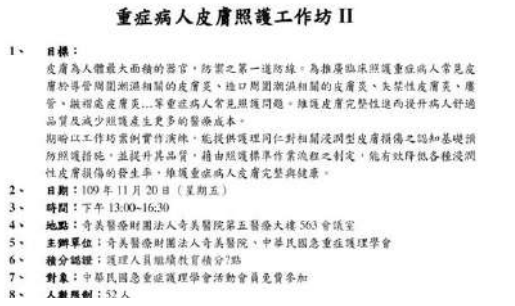
8

附件十六、IAD 評估工具資訊化平行推展附件

十六、水平展開過程紀錄序列表：

最適方策	平行推展活動內容
(一) 皮膚通氣照護標準化：	1. 2020/04/16 於加護組科會中宣導「成人紙尿布選擇與穿著術」及「紙尿布選擇醫病共享決策輔助工具」，通過決議成人加護單位進行水平展開，作業規範列入科共通作業標準。 2. 2020/05/01 完成「成人紙尿布選擇與穿著術」及「紙尿布選擇醫病共享決策輔助工具」作業規範及內容錄製成教學影片，上傳影音教學系統提供護理人員自學。 3. 擬定 2020/06/01 起至 2020/60/30 加護單位在職所有人員完成影音自學認證，並由各單位品管組自行列入定期稽核。  圖(一)：作業規範及內容掛網院內影音課程線上學習平台系統
(二) IAD 評估工具資訊化	1. 2020/3/23 資訊室撰寫傷口評估系統-IAD 評估資訊化完成。 2. 2020/3/25 傷口評估系統完成更新作業，內容涵蓋 IAD 評估工具，於三院區(總院、柳營院區、佳里院區)系統先行上線。 3. 2020/4/07 因應 COVID-19 疫情，「傷口評估」系統更新介面內容教學採以線上影音在職教育做為全院性教學，人員於公告日起自行至網路教學系統平台完成影片閱覽及課後測試，測試直至 100 分才算及格通過。 4. 2020/04/16 於加護組科會中決議通過「IAD 評估工具」、「IAD 嚴重度對應產品圖表」、「IAD 嚴重度分級工具及照護指南」三項作業標準，並請各單位負責主管帶回宣導及列入加護組科共通作業標準，同步水平展開推行。 5. 2020/05/01 前請各單位人員完成自學及線上測驗後，由傷口護理師不定期稽核。 6. 2020/05/01 將完成「IAD 嚴重度分級工具及照護指南」APP，設置於單位護理人員使用之行動護理車，供人員下載自學、應用；透過加護科組、單位網路設交媒體(LINE)群組提供教學網址(http://arkapp.pw/local/?gm=super1142)訊息傳播。

	圖(二)：Step 1 點選傷口種類  圖(三)：Step 2 點選人型圖部位　圖(四)：Step 3 IAD 評估、記錄、護理措施
(三) 增加攝入排出量跳出排便次數警示設定	2020/04/16 於加護組科會中宣導申請由視聽中心協助印製水蜜桃掛牌，5/20 全面發放各單位，以做為每日排便次數、克數超出腹瀉建議範圍時執行資訊提示之暫時替代方案作業。
(四) 系統開立醫囑時出現腹瀉用藥決策支援：	1. 2019/11/24 完成於醫囑系統設定緩瀉藥物每日極量管控，已同步水平展開至全院所有住院病人。 2. 2020/04/16 於加護組科會中提案通過「重症單位病人排便處置及照護指引、加護病房常用瀉劑 (Laxatives agent)及止瀉劑 (Antidiarrheal agent)指引」進行水平展開，同步轉提案至加護病房管理委員會，做為加護病房共通性指引。 3. 2020/04/16 申請由視聽中心協助印製「重症單位病人排便處置及照護指引、加護病房常用瀉劑 (Laxatives agent)及止瀉劑 (Antidiarrheal agent)指引」指引看板輔助工具，5/20 前發放給各單位使用。
(五) IAD 教育訓練計畫納入學習歷程計畫：	1. 2020/04/16 於加護組科會中決議通過「各層級新修訂之 IAD 教案」進行水平展開，並上呈教案內容列入科共通學習歷程，由科教育統籌年度教育訓練計畫。 2. 2020/5/1 前完成 N、N1、N2 教學影片錄製及學習後評量考題一起放入網路教學系統平台，供進階三個月、九個月、第二年以及現任 N3 和 N4 同仁自學與線上測試，線上測試成績需達 100 分方能通過認證。 3. 2020/05/05 前完成加護病房 N3 以上人員數統計，並與傷口護理師商擬 N3 與 N4 現場認證課程時數規劃。 4. 2020/5/15 於教學系統平台開立進階 N3 與 N4 傷口照護現場課程，並擬於 6/10 完成 N3 課室教學與測試需達 100 分才算及格通過，6/30 前完成 N4 人員種子教師認證，測試需達 80 分才算及格通過。 圖(五)網路教學線上測試及線上測試內容

<table>
<tr><td rowspan="6">(六)
院外推展</td><td>2020/09/24 受邀至衛生福利部嘉義醫院舉辦壓力性損傷與失禁性皮膚炎傷口照護與實作工作坊</td><td>2020/09/26 受 3M 明尼蘇達礦業及製造公司邀請至提升照護品質-皮膚照護讀書會授課</td></tr>
<tr><td>(二) 109 年 9 月 24 日 星期四
<table>
<tr><th>時間</th><th>主題</th><th>主持人/講師</th><th>授課方式</th></tr>
<tr><td>14:00~15:00</td><td>失禁性皮膚炎之評估與預防照護</td><td>莊玟玲</td><td>課堂講授</td></tr>
<tr><td rowspan="2">15:00~15:30</td><td>A組：失禁性皮膚炎之預防及處理實作</td><td>莊玟玲</td><td>實務操作</td></tr>
<tr><td>B組：失禁性皮膚炎傷口評估與敷料認識</td><td>朱麗雯</td><td>實務操作</td></tr>
<tr><td rowspan="2">15:30~16:00</td><td>B組：失禁性皮膚炎之預防及處理實作</td><td>莊玟玲</td><td>實務操作</td></tr>
<tr><td>A組：失禁性皮膚炎傷口評估與敷料認識</td><td>朱麗雯</td><td>實務操作</td></tr>
</table></td><td>
</td></tr>
<tr><td>2020/10/06 接受南天有線電視台訪問，並舉辦公益記者會宣導「正確選擇與穿著紙尿褲，有效預防失禁性皮膚炎」</td><td>2020/11/20 預計由奇美醫療財團法人奇美醫院及中華民國急重症護理學會合辦重症病人皮膚照護工作坊</td></tr>
<tr><td>
</td><td> 
重症病人皮膚照護工作坊 II
1、 目標：
皮膚為人體最大面積的器官，防禦之第一道防線。為推廣臨床照護重症病人常見皮膚於導管周圍潮濕相關的皮膚炎、造口周圍潮濕相關的皮膚炎、失禁性皮膚炎、壓瘡、濕疹皮膚炎...等重症病人常見照護問題。維護皮膚完整性進而提升病人舒適品質及減少照護產生更多的醫療成本。
期盼以工作坊案例實作演練，能提供護理同仁對相關浸潤型皮膚損傷之認知基礎預防照護措施，並提升其品質，藉由照護標準作業流程之制定，能有效降低各種浸潤性皮膚損傷的發生率，維護重症病人皮膚完整與健康。
2、 日期：109 年 11 月 20 日（星期五）
3、 時間：下午 13:00-16:30
4、 地點：奇美醫療財團法人奇美醫院第五醫療大樓 563 會議室
5、 主辦單位：奇美醫療財團法人奇美醫院、中華民國急重症護理學會
6、 積分認證：護理人員繼續教育積分7點
7、 對象：中華民國急重症護理學會活動會員免費參加
8、 人數限制：52 人</td></tr>
</table>

附件十七、參考文獻

李玉雯、林召倩(2015)．運用實證軟膏防護和照護檢核表降低加護病房病人失禁性皮膚炎發生率．*源遠護理*，*9*(2)，55-64。

李筱薇、胡瑞桃(2012)．降低加護病房病人失禁性皮膚炎之發生率．*長期照護雜誌*，*16(*2)，191-204。

林采蓉、黃敏瑢、粘惠先、劉佳琪、謝佩珊、陳淑惠(2015)．降低重症病房腹瀉病人失禁性皮膚炎發生率．*護理雜誌*，*62*(6)，81-89。

林筱青、許晉豪、楊正三(2016)．不同的皮膚照護方案對成人失禁性皮膚炎之改善成效:系統性文獻回顧．*南臺灣醫學雜誌*，*12*(2)，103-114。

施洁(2017)．*中文版 IAD 嚴重度分類工具應用於腫瘤患者 IAD 評估的信效度研究*(未發表的碩士論文)．廣西：廣西醫科大學。

莊閔仁、禹美君(2016)．降低加護病房失禁性皮膚炎發生率之專案．*長期照護雜誌*，*20*(1)，89-100。

徐筱茹、許美玉、章淑娟、鍾惠君、徐小惠(2013)．重症病人失禁性皮膚炎盛行率及預測因子之調查．*護理暨健康照護研究*，*9*(3)，210-217。

許美玉、林宜靜、陳映君(2016)．失禁性皮膚炎預防與照護圖卡．*志為護理-慈濟護理雜誌*，*15*(5)，60-63。

詹淑雅、楊美賞. (2015). 以轉換型領導營造正向病人安全文化，促進病人安全. [Transformational Leadership for Building a Positive Patient Safety Culture to Improve Patient Safety]. *長庚護理, 26*(2), 148-156. doi:10.3966/102673012015062602003

陳貞如、林子惠、施虹戎、周玫珍、王文玲(2008)．提昇護理人員對成人失禁性皮膚炎之照顧能力．*長庚護理*，*19*(1)，76-86。

趙慧玲、李怡旻、黃惠如、尹文琪(2016)．成人加護單位失禁皮膚炎相關危險因子探討．*榮總護理*，*33*(4)，388-396。

Baatenburg de Jong, H., & Admiraal, H. (2004). Comparing cost per use of 3M Cavilon No Sting Barrier Film with zinc oxide oil in incontinent patients. *Journal of Wound Care*, *13*(9), 398-400.

Beeckman, D. (2017). A decade of research on incontinence-associated dermatitis (IAD): evidence, knowledge gaps and next steps. *Journal of Tissue Viability*, *26*(1), 47-56.

Beeckman, D., Campbell, J., Campbell, K., Chiment o, D., Coyer, F., Coyer,F. & Wang, L. (2015). *Proceedings of the global IAD expert panel: Incontinence-associated dermatitis: Moving prevention forward*. Retrieved from http://www.woundsinternational.com

Beeckman, D., Verhaeghe, S., Defloor, T., Schoonhoven, L., & Vanderwee, K. (2011). A 3-in-1 perineal care washcloth impregnated with dimethicone 3% versus water and pH neutral soap to prevent and treat incontinence-associated dermatitis: a randomized, controlled clinical trial. *Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing*, *38*(6), 627-634.

Black, J. M., Gray, M., Bliss, D. Z., Kennedy-Evans, K. L., Logan, S., Baharestani, M. M., ... & Ratliff, C. R. (2011). MASD Part 2: Incontinence-Associated Dermatitis and Intertriginous Dermatitis A Consensus. *Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing, 38*(4),359-370.

Bliss, D. Z., Funk, T., Jacobson, M., & Savik, K. (2015). Incidence and Characteristics of Incontinence Associated Dermatitis in Community-Dwelling Persons with Fecal Incontinence. *Journal of wound, ostomy, and continence nursing: official publication of The Wound, Ostomy and Continence Nurses Society*, *42*(5), 525.

Bliss, D. Z., Gurvich, O. V., Hurlow, J., Cefalu, J. E., Gannon, A., Wilhems, A., ... & Trammel, S. H. (2018). Evaluation of validity and reliability of a revised incontinence-associated skin damage severity instrument (IASD. D. 2) by 3 groups of nursing staff. *Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing*, *45*(5), 449-455.

Bliss, D. Z., Gurvich, O. V., Mathiason, M. A., Eberly, L. E., Savik, K., Harms, S., ... & Virnig, B. (2017). Prevention of Incontinence-Associated Skin Damage in Nursing Homes: Disparities and Predictors. *Western Journal of Jursing Research*, *39*(5), 643-659.

Bliss, D. Z., Savik., Thorson, M. A., Ehman, S. J., Lebak, K., & Beliman, G. (2011). Incontinence-associated dermatitis in critically ill adults: time to development, severity, and risk factors. *Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing, 38*(4), 433-455.

Bliss, D. Z., Zehrer, C., Savik, K., Smith, G., & Hedblom, E. (2007). An economic evaluation of four skin damage prevention regimens in nursing home residents with in nursing home residents with incontinence: Economics of skin damage prevention. *Journal of Wound, Ostomy, and Continence Nursing, 34*(2), 143-152.

Campbell, J. L., Coyer, F. M., & Osborne, S. R. (2016). Incontinence-associated dermatitis: a cross-sectional prevalence study in the Australian acute care hospital setting. *International Wound Journal, 13*(3), 403-411.

Chianca, T. C. M., Gonçales, P. C., Salgado, P. O., Machado, B. D. O., Amorim, G. L., &Alcoforado, C. L. G. C. (2016). Incontinence-associated dermatitis: a cohort study in critically ill patients. *Revista gaucha de enfermagem, 37*(SPE).

Clemens, J. Q. (2019, August 5). *Urinary incontinence in men*. Retrieved from https://www.uptodate.com.

Cooper, P., & Gray, D. (2001). Comparison of two skin care regimes for incontinence. *British Journal of Nursing*, *10*(Sup1), S6-S20.

Coyer, F., Gardner, A., & Doubrovsky, A. (2017). An interventional skin care protocol (InSPiRE) to reduce incontinence-associated dermatitis in critically ill patients in the intensive care unit: A before and after study. *Intensive and Critical Care Nursing*, *40*, 1-10.

Donabedian, A. (1995). The role of outcomes in quality assessment and assurance. In N. O. Graham (Ed.), *Quality in theory, application, and evolution*(pp. 198-209). Gaithersburg, MD: Aspen Publishers.

Gray, M., Beeckman, D., Bliss, D. Z., Fader, M., Logan, S., Junkin, J., ... & Kurz, P. (2012). Incontinence-associated dermatitis: a comprehensive review and update. *Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing*, *39*(1), 61-74.

Gupta, S. S., Irukulla, P. K., Shenoy, M. A., Nyemba, V., Yacoub, D., & Kupfer, Y. (2017). Successful strategy to decrease indwelling catheter utilization rates in an academic medical intensive care unit. *American journal of infection control*, *45*(12), 1349-1355.

Kottner, J., Blume-Peytavi, U., Lohrmann, C., & Halfens, R. (2014). Associations between individual characteristics and incontinenceassociated dermatitis: A secondary data analysis of a multi-centre prevalence study. *International Journal of Nursing Studies, 51* (10), 1373-1380.

Kottner, J., Boronat, X., Blume-Peytavi, U., Lahmann, N., & Suhr, R. (2015). The pidemiology of skin care provided by nurses at home: a multicentre prevalence study. *Journal of advanced nursing, 71*(3), 570-580.

Kottner, J., Lichterfeld, A., & Blume-Peytavi, U. (2013). Maintaining skin integrity in the aged: A systematic review. *British Journal of Dermatology, 169*(3), 528-542.

Pather, P. (2018). *Incidence and measurement of incontinence-associated dermatitis in adult intensive care patients (Doctoral dissertation).* Retrieved from *https://eprints.qut.edu.au/115804/1/Priscilla_Pather_Thesis.pdf*

Pather, P., & Hines, S. (2016). Best practice nursing care for ICU patients with incontinence-associated dermatitis and skin complications resulting from faecal incontinence and diarrhoea. *International journal of evidence-based healthcare*, *14*(1), 15-23.

Robson, K. M., & Lembo, A. J. (2018, August 5). *Fecal incontinence in adults: Etiology and evaluation.* Retrieved from https://www.uptodate.com.

Valls-Matarín, J., del Cotillo-Fuente, M., Ribal-Prior, R., Pujol-Vila, M., & Sandalinas-Mulero, I. (2017). Incidence of moisture-associated skin damage in an intensive care unit. *Enfermería Intensiva (English ed.)*, *28*(1), 13-20.

Van den Bussche, K., Verhaeghe, S., Van Hecke, A., & Beeckman, D. (2018). Minimum Data Set for Incontinence-Associated Dermatitis (MDS-IAD) in adults: Design and pilot study in nursing home residents. *Journal of tissue viability*, *27*(4), 191-198.

Wang, X., Zhang, Y., Zhang, X., Zhao, X., & Xian, H. (2018). Incidence and risk factors of incontinence-associated dermatitis among patients in the intensive care unit. *Journal of clinical nursing*, *27*(21-22), 4150-4157.

Wei, L., Bao, Y., Chai, Q., Zheng, J., & Xu, W. (2019). Determining Risk Factors to Develop a Predictive Model of Incontinence-associated Dermatitis Among Critically Ill Patients with Fecal Incontinence: A Prospective, Quantitative Study. *Wound management & prevention*, *65*(4), 24-33.

Williams, C. (2001). 3M Cavilon Durable Barrier Cream in skin problem management. *BritishJournal of Nursing*, *10*(7), 469-472.

Zhou, X. L., He, Z., Chen, Y. H., & Zuo, L. E. (2017). Effect of a 1-Piece Drainable Pouch on Incontinence-Associated Dermatitis in Intensive Care Unit Patients With Fecal Incontinence. *Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing*, *44*(6), 568-571.